TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA ĐIỀU DƯỠNG & KỸ THUẬT Y HỌC

TÀI LIỆU HỘI THẢO

THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

CẦN THƠ, năm 2022

Nội dung được thiết kế và xây dựng bởi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CHỦ BIÊN:

PGS.TS.BS.Phạm Lê An

BAN BIÊN SOẠN:

PGS.TS.BS.Phạm Lê An

ThS.ĐD.Ngô Thị Dung

CNĐD.Mai Nguyễn Thanh Trúc

BAN BIÊN TẬP:

PGS.TS.BS.Phạm Lê An

CNĐD. Mai Nguyễn Thanh Trúc

Nội dung được thiết kế và xây dựng bởi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

LỜI NÓI ĐẦU

Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của các nước trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, Điều dưỡng được xem là ngành nghề có vai trò như "xương sống" trong việc chăm sóc người bệnh. Bên cạnh đó, do dân số ngày càng tăng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao, đòi hỏi điều dưỡng cần phải học tập và trau dồi trình độ chuyên môn của bản thân.

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, thực hành dựa trên bằng chứng được xem là một trong những xu hướng hiện đại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Nhằm bắt kịp xu hướng hiện đại, cung cấp chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh và đáp ứng nhu cầu "học tập suốt đời" cho đội ngũ điều dưỡng viên. Chúng tôi tiến hành biên soạn quyển tài liệu này giúp cung cấp cho người đọc những nội dung cơ bản nhất về nguyên lý thực hành dựa trên bằng chứng trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng.

Quyển tài liệu được hoàn thành nhờ vào sự hỗ trợ của giảng viên Trung tâm Đào tạo Bác sĩ gia đình của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và giảng viên khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Chúng tôi hy vọng quyển tài liệu này sẽ góp phần tích cực vào chương trình đào tạo cũng như quá trình chăm sóc điều dưỡng của Qúy đồng nghiệp.

Lần đầu biên soạn, sách vẫn còn nhiều thiếu sót, hy vọng sẽ nhận được sự góp ý của Quý đồng nghiệp và sinh viên để ngày càng hoàn thiện hơn.

Thay mặt ban biên soạn

PGS.TS.BS.Phạm Lê An

Trưởng Trung tâm đào tạo Bác sĩ Gia đình

Giám đốc trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo (GIC)

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. Thực hành dựa trên bằng chứng là gì. **Error! Bookmark not defined.**
CHƯƠNG II. Nghiên cứu điều dưỡng và thực hành dựa trên bằng chứng..... 18
CHƯƠNG III. Câu hỏi thực hành 26
CHƯƠNG IV. Phân tích và thẩm định bằng chứng..... 35
CHƯƠNG V. Tạo môi trường hỗ trợ cho thực hành dựa trên bằng chứng 52

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ANA	American Nurses Association
CINHAL	Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
CURN	Conduct and Utilization of Research in Nursing project
EBP	Evidence – Based Practice
GRADE	Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations
ICU	Intensive Care Unit
IOM	Institute of Medicine
PICOT	Population - Intervention – Comparision – Outcome - Time
QI	Quality of Improvements
RCTs	Randomized Control Trials
RNs	Registered Nurses
WICHEN	Western Interstate Commission for Higher Education in Nursing

CHƯƠNG I.
THỰC HÀNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG LÀ GÌ?

Nhiều sinh viên đã đặt câu hỏi về việc cần thiết phải học một cuốn sách như thế này. Nhiều sinh viên thấy việc đồng hành cùng người bệnh trong các bối cảnh khác nhau là quan trọng và tạo cảm hứng. Là một nhân viên mới, thường khó có thể đánh giá được giá trị của việc học hỏi quá trình nghiên cứu và tầm quan trọng của bằng chứng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh. Để đánh giá tầm quan trọng của bằng chứng, hãy tưởng tượng rằng một thành viên trong gia đình đưa ra yêu cầu về chăm sóc điều dưỡng. Liệu việc chăm sóc dựa trên bằng chứng có đáng mong đợi hơn là dựa trên truyền thống, thử và sai, hoặc một phỏng đoán từ kiến thức? Để là một điều dưỡng có năng lực, điều dưỡng phải có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng. Hành trình xuyên suốt cuốn sách này sẽ hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng và tài năng của mình trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh dựa trên bằng chứng để có thể đạt được kết quả tốt nhất có thể như một cách chăm sóc cơ bản.

1. Thế nào là thực hành dựa trên bằng chứng (EBP)?

1.1. Tổng quan về EBP

Khi xem xét tài liệu về EBP, người ta sẽ tìm thấy nhiều định nghĩa khác nhau. Hầu hết các định nghĩa bao gồm ba thành phần: thông tin dựa trên nghiên cứu, chuyên môn lâm sàng và mong muốn của người bệnh. Định nghĩa của Ingersoll (2000) nắm bắt một cách ngắn gọn bản chất của EBP, đó là "việc sử dụng một cách tận tâm, rõ ràng và thận trọng thông tin dựa trên lý thuyết, dựa trên nghiên cứu để đưa ra quyết định về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các cá nhân hoặc nhóm người bệnh và xem xét các nhu cầu và mong muốn của cá nhân" (tr.52). Điều đó có nghĩa là gì?

EBP là một quá trình liên quan đến việc kiểm tra và áp dụng các kết quả nghiên cứu hoặc bằng chứng đáng tin cậy khác đã được tích hợp với các lý thuyết khoa học. Đối với điều dưỡng khi tham gia vào quá trình này, họ phải sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để xem xét các tài liệu nghiên cứu và các nguồn thông tin khác. Sau khi thông tin được đánh giá, điều dưỡng sử dụng các kỹ năng ra quyết định về lâm sàng để áp dụng bằng chứng vào việc chăm sóc người bệnh. Trong tất cả các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, mong muốn và nhu cầu của người bệnh là cơ sở của các quyết định về chăm sóc và do đó EBP cơ bản là có nguồn gốc từ y học. Archie Cochrane, nhà dịch tễ học người Anh, đã cảnh báo ngành y tế vì đã không kiểm tra các bằng chứng một cách nghiêm túc (Cochrane, 1971). Ông cho rằng các cá nhân chỉ nên trả tiền cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học (Melnyk & Fineout-Overholt, 2005) và ông tin rằng các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên là "tiêu chuẩn vàng" để tạo ra bằng chứng

đáng tin cậy và hợp lệ. Ông cho rằng nên tiến hành các đánh giá nghiêm túc, có hệ thống về nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực khác nhau để cung cấp thông tin cho thực tiễn và hoạch định chính sách. Kết quả của ý tưởng đổi mới này là Trung tâm Cochrane đã thành lập một tổ chức hợp tác "dành riêng cho việc cung cấp thông tin cập nhật, chính xác về ảnh hưởng của việc chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Nó [Trung tâm Cochrane] đưa ra và phổ biến các tổng quan hệ thống về các can thiệp chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy việc tìm kiếm bằng chứng dưới dạng các thử nghiệm lâm sàng và các nghiên cứu khác về can thiệp" (The Cochrane Collaboration, n.d.). Các định nghĩa khác được xây dựng dựa trên triết lý của Tiến sĩ Cochrane và định nghĩa về EBP trong y học đã phát triển để đưa vào các đánh giá lâm sàng và mong muốn của người bệnh (Sackett, Rosenberg, Grey, Haynes, & Richardson, 1996; Straus, Richardson, Glasziou, & Haynes, 2005). Trong thời gian này, điều dưỡng tham gia rất nhiều vào việc cố gắng áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế, một quá trình được gọi là sử dụng nghiên cứu. Quá trình này bao gồm việc thay đổi thực hành từ kết quả của một nghiên cứu duy nhất (Barnsteiner & Prevost, 2002).

Các nhà đổi mới điều dưỡng nhận ra rằng việc chuyển từ mô hình này sang mô hình EBP sẽ có nhiều khả năng cải thiện kết quả của người bệnh và cung cấp các phương pháp chăm sóc hiệu quả hơn về chi phí (Ingersoll, 2000; Melnyk, 1999; Youngblut & Brooten, 2001). Tại sao? Nhiều câu hỏi về điều dưỡng không thể được trả lời bằng một nghiên cứu duy nhất và điều kiện của con người không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng được với các thử nghiệm lâm sàng. Ngoài ra, quá trình sử dụng nghiên cứu không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc ra quyết định lâm sàng, cũng như không chú ý đến việc sự tập trung vào người bệnh. Những nhà đổi mới này đã nhận ra rằng mô hình EBP cho phép xem xét các nguồn bằng chứng khác có liên quan đến thực hành điều dưỡng.

1.2. Sơ lược về lịch sử

EBP không phải là khái niệm mới; nguồn gốc của nó kéo dài qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, như với bất kỳ khoa học ứng dụng nào, các thuật ngữ liên quan đến thực hành dựa trên bằng chứng đã thay đổi khi khoa học phát triển. Ngay từ năm 1972, Archibald L. Cochrane, nhà dịch tễ học người Anh, đã chỉ trích ngành y tế vì thực hiện các phương pháp điều trị mà không dựa trên bằng chứng (Cochrane, 1972).

Vào những năm 1980, thuật ngữ y học dựa trên bằng chứng đã được sử dụng tại Trường Đại học Y khoa McMaster ở Canada. Sự đón nhận tích cực đối với các tổng quan hệ thống về chăm sóc trong thời kỳ mang thai và sinh nở đã thúc đẩy Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh vào năm 1992 phê duyệt tài trợ cho "Trung tâm Cochrane" để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị

các tổng quan hệ thống về các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng về chăm sóc y tế, cuối cùng dẫn đến việc thành lập tổ chức Hợp tác Cochrane năm 1993 (The Cochrane Collaboration, 2011). Tổ chức Hợp tác Cochrane cung cấp các tổng quan hệ thống về hiệu quả của việc chăm sóc y tế. Những tổng quan này cung cấp lý luận logic và bằng chứng xác đáng để đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả.

Dựa trên những nỗ lực ban đầu này, thực hành dựa trên bằng chứng đã phát triển để đưa vào các kỹ thuật phân tích ngày càng phức tạp; cải thiện trình bày và phổ biến thông tin; nâng cao kiến thức về cách áp dụng các kết quả trong khi cân nhắc một cách hiệu quả các mong muốn của người bệnh, chi phí và các vấn đề chính sách; và hiểu rõ hơn về cách đo lường hiệu quả và sử dụng phản hồi để thúc đẩy liên tục.

Điều dưỡng có một lịch sử phong phú về việc sử dụng nghiên cứu trong thực hành, đi tiên phong bởi Florence Nightingale, người đã sử dụng dữ liệu để thay đổi những thực hành đã gây ra tỷ lệ tử vong cao trong bệnh viện và cộng đồng (Nightingale, 1858, 1859, 1863a, 1863b). Bắt đầu từ những năm 1970, khoa học điều dưỡng đã phát triển và các kết quả đã có sẵn để hướng dẫn thực hành. EBP (được gọi là áp dụng nghiên cứu) đã được nâng cao bởi các dự án và chương trình mô tả như sau:

• Tiến hành và sử dụng dự án Nghiên cứu trong Điều dưỡng (CURN) (Horsley và cộng sự, 1983),

• Chương trình phát triển nghiên cứu điều dưỡng khu vực của Ủy ban liên bang Miền Tây về giáo dục điều dưỡng nâng cao (WICHEN) (Kreuger, 1978; Kreuger, Nelson, & Wolanin, 1978; Lindeman & Krueger, 1977),

• Dự án Đào tạo Vệ tinh Đánh giá chăm sóc Trẻ em (NCAST; King, Barnard, và Hoehn, 1981),

• Dự án đưa Kiến thức mới vào Thực hành (Cronenwett, 1995; Funk, Tornquist, & Champagne, 1989)

• Dự án Áp dụng Nghiên cứu trong chăm sóc tại Quận Cam (Rutledge & Donaldson, 1995).

Những dự án cụ thể này đã đặt nền tảng cho việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế để cải thiện việc chăm sóc người bệnh, ngày nay được gọi là thực hành dựa trên bằng chứng. Gần đây hơn, nghề điều dưỡng đã cung cấp vai trò lãnh đạo chính trong việc cải thiện dịch vụ chăm sóc thông qua EBP (Kirchhof, 2004), và ngày nay điều dưỡng đang dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học dịch thuật (Brooks và cộng sự, 2009; Thành lập và cộng sự, 2008; Newhouse và cộng sự. , 2013; Titler và cộng sự, 2009, 2016; Wilson và cộng sự, 2016), và EBP (Dickinson & Shever, 2012; Dockham và cộng sự, 2016; Kelly & Titler, 2010; Kueny

và cộng sự, 2015; Madsen và cộng sự, 2005; Mark, Titler, & Lattimer, 2014; Shever & Dickinson, 2013; Titler & Moore, 2010; Titler, 2010, 2011, 2014). Kết quả là, cơ quan khoa học về dịch kiến thức và ứng dụng bằng chứng trong chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển. Những tiến bộ trong khoa học thực hiện có thể thúc đẩy và duy trì việc tích hợp thành công các bằng chứng trong thực tế để cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc, sức khỏe dân số và kết quả sức khỏe (Henly và cộng sự, 2015).

1.3. Định nghĩa các thuật ngữ

Có nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong lĩnh vực EBP. Điều cần thiết là điều dưỡng phải bắt đầu hoặc thúc đẩy sự tham gia của mình vào EBP bằng cách kết tinh sự hiểu biết của mình về sự khác biệt giữa tiến hành nghiên cứu và EBP. Chúng tôi sẽ lưu ý rằng EBP và tiến hành nghiên cứu có các mục đích, câu hỏi, cách tiếp cận và phương pháp đánh giá riêng biệt.

Tiến hành nghiên cứu là việc điều tra một cách có hệ thống một hiện tượng để trả lời các câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu nhằm tạo ra tri thức mới và nâng cao trạng thái của khoa học. Ví dụ: với tư cách là một nhà điều tra, bạn có thể đang kiểm tra tính hiệu quả của một ứng dụng điện tử di động được thiết kế để cải thiện khả năng tự chăm sóc của những người bệnh suy tim (HF) vì tình trạng khoa học còn nhiều nghi vấn và các nghiên cứu trước đây không được cấp phép với kích thước mẫu nhỏ. Là một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, nghiên cứu của bạn nhằm mục đích nâng cao khoa học bằng cách sử dụng thiết kế chặt chẽ hơn, trong đó các đối tượng trong nghiên cứu của bạn sẽ đáp ứng các tiêu chí bao gồm cụ thể và được ngẫu nhiên hóa vào nhóm thử nghiệm hoặc so sánh. Các biện pháp quản lý tự chăm sóc với độ tin cậy và hiệu lực đã được chứng minh sẽ được thu thập tại thời điểm ban đầu, sau khi hoàn thành can thiệp và cho các mốc thời gian theo dõi cụ thể. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, bạn sẽ phổ biến nghiên cứu của mình tại các hội nghị khoa học và trên các tạp chí khoa học.

Thực hành dựa trên bằng chứng là việc sử dụng một cách công tâm và thận trọng các bằng chứng tốt nhất hiện tại kết hợp với chuyên môn lâm sàng, giá trị của người bệnh và hoàn cảnh để hướng dẫn các quyết định chăm sóc sức khỏe (Straus, Glasziou , Richardson, & Haynes, 2011; Titler , 2014). Bằng chứng tốt nhất bao gồm các phát hiện từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, bằng chứng từ các thiết kế khoa học khác như nghiên cứu mô tả và định tính, cũng như thông tin từ các báo cáo trường hợp và các nguyên tắc khoa học. Khi có đủ bằng chứng nghiên cứu đáng tin cậy, việc thực hành cần được hướng dẫn bởi các kết quả nghiên cứu kết hợp với chuyên môn lâm sàng và các giá trị của người bệnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ sở nghiên cứu thiếu hụt có thể không có sẵn và việc ra quyết định chăm

sóc sức khỏe chủ yếu dựa trên các nguồn bằng chứng khác như các nguyên tắc khoa học, báo cáo trường hợp và kết quả của các dự án cải tiến chất lượng (QI). Ví dụ, có một cơ sở bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng một can thiệp giáo dục tâm lý cho các người bệnh ung thư tuổi trưởng thành và những người chăm sóc cung cấp cho họ thông tin và hỗ trợ để cải thiện khả năng đối phó và chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm bớt sự lo lắng (Dockham và cộng sự, 2016; Northouse et al., 2005, 2007, 2010, 2013).

Khi nghĩ đến việc sử dụng biện pháp can thiệp này trong thực hành của bạn, bạn sẽ cần cân nhắc những điều sau:

• Các thành phần của can thiệp,

• Cho dù bạn hoặc nhân viên khác có chuyên môn để thực hiện sự can thiệp này hay không,

• Nhận thức của quần thể người bệnh ung thư mà bạn chăm sóc, và

• Bạn sẽ thực hiện can thiệp này trong hoàn cảnh nào (ví dụ, người bệnh ung thư mới được chẩn đoán so với những người bệnh cuối đời).

Khi đưa ra những quyết định này, bạn sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng các nghiên cứu về những điều sau:

• Nhiều thành phần của can thiệp tâm lý được thử nghiệm,

• Thiết lập và định dạng trong đó nó đã được thử nghiệm (định dạng nhóm gồm ba hoặc bốn người trong cơ quan cộng đồng hỗ trợ ung thư; người làm việc riêng lẻ trong nhà),

• Tiêu chuẩn và đào tạo chuyên môn của nhà can thiệp (ví dụ: điều dưỡng chuẩn bị cho thạc sĩ, nhân viên xã hội chuẩn bị cho thạc sĩ được cấp phép),

• Các tiêu chí bao gồm và loại trừ của các đối tượng (người bệnh và người chăm sóc) được đưa vào các nghiên cứu.

Cải tiến chất lượng vừa là triết lý hoạt động của tổ chức, vừa là một tập hợp các công cụ phân tích và thay đổi kỹ thuật để giảm bớt sự khác biệt về chất lượng chăm sóc do các tổ chức chăm sóc sức khỏe cung cấp (Nelson và cộng sự, 2007). Dự án cải tiến chất lượng (QI) nhấn mạnh đến sự hài lòng của người bệnh, đội ngũ và tinh thần đồng đội cũng như việc cải tiến liên tục các quy trình làm việc. Các tính năng xác định khác bao gồm thiết lập các mục tiêu và kỳ vọng về hiệu suất của tổ chức, sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và tiêu chuẩn hóa các quy trình làm việc để giảm sự khác biệt giữa các nhà cung cấp và các cuộc gặp gỡ dịch vụ (Nelson và cộng sự, 2007).

1.4. EBP và kết quả

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, về bản chất, luôn quan tâm đến kết quả của việc chăm sóc người bệnh. Theo truyền thống, các kết quả như vậy đã được đặc trưng bởi

các thuật ngữ về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Tuy nhiên, gần đây, trọng tâm đã được mở rộng để bao gồm các kết quả lâm sàng (ví dụ: điều trị), kết quả về chức năng (ví dụ, thực hiện các hoạt động hàng ngày), kết quả về chất lượng cuộc sống (ví dụ, sự hài lòng của người bệnh) và kết quả về kinh tế (ví dụ: chi phí trực tiếp, gián tiếp, và chi phí vô hình). EBP là một quy trình rõ ràng trong đó các nhà lâm sàng tiến hành đánh giá bằng chứng nghiêm túc và kiểm tra mối liên hệ giữa thực hành chăm sóc sức khỏe và kết quả để đưa ra các quyết định và cải thiện chất lượng chăm sóc.

1.5. Chấp nhận thực hành dựa trên bằng chứng (EBP)

Người ta cho rằng khi có bằng chứng khoa học thuyết phục, các kết quả sẽ chuyển sang thực hành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, điều này thường không xảy ra. Nhiều rào cản làm phức tạp thêm việc đem các kết quả nghiên cứu vào thực hành.

Trên thực tế, có thể mất tới 200 năm để một sự đổi mới trở thành một tiêu chuẩn chăm sóc. Ngay cả khi những lợi ích và lợi thế của sự đổi mới đã được chứng minh, việc áp dụng vẫn có thể chậm xảy ra. Thậm chí cho đến nay, các nghiên cứu cho thấy điều dưỡng không sử dụng nghiên cứu điều dưỡng trong thực hành. Gần đây, một cuộc khảo sát điều dưỡng trên khắp nước Mỹ đã được thực hiện. Trong số các điều dưỡng lâm sàng trả lời khảo sát, hơn 54% không quen thuộc với thuật ngữ EBP. 67% nguồn thông tin này là từ các đồng nghiệp. Đáng báo động là 58% người được hỏi chưa bao giờ sử dụng các bài báo nghiên cứu để hỗ trợ thực hành lâm sàng.

Chỉ 18% đã từng sử dụng thư viện bệnh viện. Ngoài ra, 77% chưa bao giờ được hướng dẫn sử dụng các nguồn điện tử (Pravikoff , Tanner, & Pierce, 2005).

1.6. Mô hình và thực hành dựa trên bằng chứng

Mô hình dựa trên bằng chứng là khuôn mẫu hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo lâm sàng và nhóm của họ khi họ quyết định khởi động, thực hiện và hoàn thành một dự án dựa trên bằng chứng để nâng cao chất lượng chăm sóc. Hãy nghĩ về các mô hình thực hành dựa trên bằng chứng như bạn nghĩ về việc xây dựng một ngôi nhà. Đối với một ngôi nhà, các thành phần của mô hình EBP cung cấp nền móng, sàn nhà, tường và mái nhà hoặc trong trường hợp này là tất cả các bộ phận cấu thành của quy trình EBP.

Tương tự, có các mô hình xây dựng các dự án cải tiến chất lượng (QI). Một ngôi nhà được xây dựng theo một trình tự cụ thể; vì vậy, các dự án EBP và QI được thiết kế, thực hiện và đánh giá theo một trình tự cụ thể được hướng dẫn bởi các bước của một mô hình cụ thể.
Bằng chứng từ các nghiên cứu đã được công bố và chưa được công bố, được sử dụng cho việc đưa ra quyết định lâm sàng về việc áp dụng các kết quả vào thực tế.

a. Mô hình IOWA về thực hành dựa trên bằng chứng

Mô hình Iowa về Thực hành dựa trên bằng chứng, như một ví dụ về mô hình EBP. Mô hình này dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, đã được phổ biến và áp dụng rộng rãi trong các cơ sở học thuật và lâm sàng kể từ khi ra đời (Titler và cộng sự, 2001). Các bước của mô hình như sau:

- Lựa chọn chủ đề
- Thành lập nhóm
- Thu thập bằng chứng
- Phân loại bằng chứng
- Thẩm định và tổng hợp bằng chứng
- Đưa ra các khuyến nghị thực hành dựa trên bằng chứng.
- Phát triển thực hành dựa trên bằng chứng
- Thực hiện và phổ biến (các) thay đổi thực hành
- Đánh giá sự thay đổi

b. Mô hình John Hopkins

Mô hình thực hành chăm sóc dựa trên bằng chứng Johns Hopkins (JHNEBP) mô tả ba trụ cột chủ yếu làm nền tảng cho thực hành nghề nghiệp điều dưỡng: thực hành, giáo dục và nghiên cứu.

• Thực hành, thành phần cơ bản của tất cả các hoạt động điều dưỡng (Porter-O'Grady, 1984), phản ánh việc chuyển những gì điều dưỡng biết thành những gì họ làm. Đó là: ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và bằng cách nào thực hành thể hiện phạm vi hoạt động điều dưỡng xác định hoạt động chăm sóc cho người bệnh (Hội điều dưỡng Mỹ [ANA], 2010). Đây là một thành phần không thể thiếu của các tổ chức chăm sóc y tế.

• Giáo dục phản ánh việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng điều dưỡng cần thiết để xây dựng chuyên môn và duy trì năng lực.

• Nghiên cứu tạo ra kiến thức mới cho nghề nghiệp và cho phép phát triển thực hành dựa trên bằng chứng khoa học. Điều dưỡng không chỉ "dựa vào bằng chứng này để định hướng chính sách và thực hành của họ, mà còn là một cách để đánh giá tác động của điều dưỡng đối với kết quả về sức khỏe của người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe" (Hội Điều dưỡng Mỹ, 2010, trang 22).

c. Giáo dục điều dưỡng và mô hình John Hopkins

Giáo dục điều dưỡng bắt đầu với giáo dục cơ bản (nói chung là bằng cao đẳng hoặc bằng cử nhân) trong đó có các kỹ năng và kiến thức điều dưỡng cơ bản, khoa học tự nhiên và khoa học hành vi, các giá trị nghề nghiệp, hành vi và thái độ. Giáo dục nâng cao (bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ) mở rộng kiến thức dựa trên lý thuyết, tinh chỉnh thực hành và thường dẫn đến chuyên

môn hóa trong một lĩnh vực thực hành cụ thể. Giáo dục điều dưỡng nâng cao kết hợp việc tăng cường áp dụng nghiên cứu và các loại bằng chứng khác để tác động hoặc thay đổi thực hành điều dưỡng và hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Đào tạo liên tục, chẳng hạn như hội nghị, hội thảo, hội thảo và đào tạo tại chỗ, cần cập nhật kiến thức, công nghệ và kỹ năng mới hoặc luôn xây dựng năng lực lâm sàng. Vì lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng trở nên phức tạp và mang tính kỹ thuật hơn, không ai có thể biết mọi thứ về việc làm sao để cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và hiệu quả nhất, và không một bằng cấp nào có thể cung cấp kiến thức cần thiết cho toàn bộ sự nghiệp chuyên môn. Do đó, điều cần thiết là điều dưỡng phải tham gia vào quá trình học tập suốt đời và nâng cao năng lực liên tục (IOM, 2011). Học tập suốt đời không chỉ là học tập cá nhân mà còn là học tập liên ngành, hợp tác và học theo nhóm. Ví dụ: sử dụng mô phỏng và đào tạo trên web để giáo dục sinh viên y khoa cùng với sinh viên điều dưỡng về vai trò và trách nhiệm, giao tiếp hiệu quả, giải quyết xung đột và ra quyết định chung được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp hợp tác sẵn sàng làm việc hiệu quả trong các nhóm làm việc lấy người bệnh làm trung tâm. Hơn nữa, việc sử dụng giáo dục liên ngành được cho là sẽ thúc đẩy sự hợp tác trong việc thực hiện các chính sách, cải thiện dịch vụ và trang bị cho các nhóm giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng của một thành viên trong nhóm (IOM, 2011).

***Nghiên cứu điều dưỡng và thực hành dựa trên bằng chứng**

Nghiên cứu điều dưỡng sử dụng các phương pháp hệ thống định tính và định lượng và phương pháp tiếp cận EBP hướng đến việc nghiên cứu và nâng cao chăm sóc người bệnh, hệ thống chăm sóc và kết quả điều trị. Mặc dù người ta thường chấp nhận rằng các thực hành tốt nhất dựa trên các quyết định dựa trên bằng chứng khoa học, hợp lý. Trên thực tế, các nghiên cứu hiện tại được chuyển thành thực hành chăm sóc thường chậm chạp.

Nhiều điều dưỡng bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó bởi những gì được gọi là kiến thức, trong đó họ dần thấy cần phải thay đổi thực hành dựa trên các nghiên cứu hạn chế và truyền miệng (Pape & Richards, 2010). Tạo cấu trúc và hỗ trợ cho các điều dưỡng sử dụng bằng chứng trong thực hành lâm sàng giúp thu hẹp khoảng cách giữa thực hành và bằng chứng (Oman, Duran, & Fink, 2008). Các nhà lãnh đạo điều dưỡng cần hỗ trợ và khuyến khích khả năng và sử dụng nghiên cứu điều dưỡng để tạo ra kiến thức mới, thông tin về thực hành và nâng cao chất lượng kết quả chăm sóc. Để thực hiện được điều này, các tổ chức cần xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc thông qua việc phát triển các cố vấn, các chương trình xây dựng kỹ năng, hỗ trợ tài chính, truy cập máy tính và các dịch vụ tư vấn nghiên cứu.

**** Các yếu tố bên trong và bên ngoài của mô hình thực hành dựa trên chứng cứ John Hopkins***

Các yếu tố bên ngoài có thể bao gồm các cơ quan công nhận, luật pháp, đo lường chất lượng, quy định và tiêu chuẩn. Các cơ quan công nhận (ví dụ: Ủy ban liên hợp, Hội đồng chứng nhận cơ sở phục hồi chức năng quốc tế) yêu cầu một tổ chức đạt được và duy trì các tiêu chuẩn cao về chất lượng và thực hành. Các cơ quan lập pháp và quản lý (địa phương, tiểu bang và liên bang) ban hành luật và quy định được thiết lập để bảo vệ cộng đồng và thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, an toàn. Việc không tuân theo luật pháp và quy định này có ảnh hưởng xấu đến tổ chức, thường là về mặt tài chính. Ví dụ về các cơ quan quản lý bao gồm Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, và Hội điều dưỡng tiểu bang.

Các hội điều dưỡng tiểu bang quy định việc thực hành điều dưỡng và thực thi các Hoạt động Hành nghề điều dưỡng, nhằm bảo vệ cộng đồng. Đo lường chất lượng (dữ liệu về kết quả và hiệu suất) và các tiêu chuẩn chuyên môn đóng vai trò là thước đo để đánh giá hoạt động hiện tại và xác định các lĩnh vực cần cải tiến hoặc thay đổi. Trung tâm chứng nhận điều dưỡng Mỹ, thông qua Chương trình chứng nhận Magnet®, đã phát triển các tiêu chí để đánh giá chất lượng điều dưỡng và điều dưỡng xuất sắc trong các tổ chức. Ngoài ra, nhiều bên liên quan bên ngoài như mạng lưới chăm sóc sức khỏe, các nhóm/tổ chức có quan tâm đặc biệt, nhà cung cấp, người bệnh và gia đình người bệnh, cộng đồng và người chi trả bên thứ ba có ảnh hưởng đến các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Bất chấp sự đa dạng giữa các yếu tố bên ngoài này, một xu hướng chung là mong muốn rằng các tổ chức đặt các tiêu chuẩn và thực hành chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng xác thực.

Các yếu tố bên trong có thể bao gồm văn hóa, giá trị và niềm tin của tổ chức; môi trường thực hành (ví dụ: lãnh đạo, phân bổ nguồn lực, dịch vụ cho người bệnh, sứ mệnh và ưu tiên của tổ chức, tính sẵn có của công nghệ, hỗ trợ từ thư viện); trang thiết bị; nhân sự; và các tiêu chuẩn của tổ chức. Việc thúc đẩy sử dụng EBP trong một tổ chức yêu cầu:

- Văn hóa tin rằng EBP sẽ dẫn đến kết quả tối ưu cho người bệnh.
- Hỗ trợ mạnh mẽ từ lãnh đạo ở tất cả các cấp với sự phân bổ nguồn lực cần thiết (nhân lực, công nghệ và tài chính) để duy trì quá trình.
- Mong muốn kết hợp EBP vào các tiêu chuẩn và mô tả công việc. Kiến thức và đánh giá từ người bệnh, tổ chức chăm sóc sức khỏe, và các yếu tố bên trong và bên ngoài là cần thiết để thực hiện và duy trì thành công EBP trong một tổ chức.

1.7. Vai trò của điều dưỡng trong EBP

EBP bao gồm nhiều nguồn kiến thức, chuyên môn lâm sàng và mong muốn của người bệnh. Do vị trí và chuyên môn độc nhất của họ tại giường bệnh, điều dưỡng thường đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra các câu hỏi về chăm sóc và an toàn người bệnh.

Điều này, cùng với thực tế là các câu hỏi và mối quan tâm về thực hành thường liên quan nhiều chuyên ngành, khiến việc tập hợp một nhóm liên ngành và có sự tham tham gia của người bệnh và gia đình họ là rất quan trọng. Do đó, điều dưỡng cần phải phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết không chỉ để tham gia vào quy trình EBP mà còn để thực hiện tư cách là người lãnh đạo các nhóm EBP liên ngành tìm kiếm các phương pháp thực hành tốt nhất để

nâng cao chăm sóc người bệnh. Điều dưỡng và lãnh đạo điều dưỡng cũng đóng vai trò trung tâm trong việc mô hình hóa và thúc đẩy văn hóa hỗ trợ việc sử dụng EBP hợp tác trong tổ chức và đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết (ví dụ: thời gian, giáo dục, thiết bị, cố vấn và hỗ trợ thư viện) được cung cấp để tạo điều kiện và duy trì quá trình.

1.8. Vượt qua rào cản

Các nghiên cứu chứng minh rằng những nguyên nhân làm điều dưỡng không theo nghiên cứu liên quan đến các yếu tố cá nhân và tổ chức.

Yếu tố cá nhân là những đặc điểm vốn có của điều dưỡng. Các yếu tố tổ chức liên quan đến quản trị, nguồn lực, cơ sở vật chất và văn hóa của hệ thống. Những rào cản như điều dưỡng không đánh giá được nghiên cứu, không thích thay đổi, hoặc thiếu thời gian và nguồn lực để thu thập bằng chứng (Pravikoff và cộng sự, 2005) là những lý do chính khiến điều dưỡng không sử dụng kết quả nghiên cứu vào chăm sóc. Ngoài ra, khoảng cách giao tiếp giữa nhà nghiên cứu và nhà lâm sàng (Brown, 1995), văn hóa tổ chức, cũng như thiếu khả năng đánh giá nghiên cứu điều dưỡng được xác định bởi chính các điều dưỡng, nhà quản lý y tế, hộ sinh và điều dưỡng chuyên ngành ung thư (Barta , 1995 ; Carroll và cộng sự, 1997; Funk, Champagne, Tornquist , & Wiese, 1995; Funk, Champagne, Wiese, & Tornquist , 1991; Kajermo , Nordstrom, Krusebrant , & Bjorvell , 2000; Meah , Luker , & Cullum, 1996; Pettengill, Gillies, & Clark, 1994; Rutledge, Ropka , Greene, Nail, & Mooney, 1998). Các chiến lược không vượt qua được những rào cản này sẽ ít thúc đẩy EBP.

Để vượt qua các rào cản liên quan đến các yếu tố cá nhân, các chiến lược cần phải nhằm mục đích thúc đẩy sự coi trọng EBP, nâng cao kiến thức, phát triển các kỹ năng cần thiết và thay đổi hành vi. Các chiến lược để vượt qua các rào cản của tổ chức phải hướng tới việc tạo ra và duy trì một môi trường mà EBP có thể phát triển. Nghiên cứu đã tập trung vào các chiến lược để vượt qua cả yếu tố cá nhân và yếu tố tổ chức để mang lại sự thay đổi (Camiah, 1997; Caramanica và cộng sự, 2002; Dufault, 2001; Janken, Dufault, & Yeaw, 1988; Maljanian, Caramanica, Taylor, MacRae, & Beland, 2002).

Bảng 1. Các chiến lược để vượt qua các rào cản trong việc áp dụng EBP

Rào cản	**Chiến lược giải quyết**
Thời gian	- Dành 15 phút mỗi ngày để đọc bằng chứng liên quan đến vấn đề lâm sàng - Đăng kí email để được cung cấp tài liệu trong lĩnh vực nghiên cứu quan tâm - Sử dụng phương pháp tiếp cận nhóm khi xem xét các thay đổi chính sách để phân chia khối lượng công việc giữa các thành viên

	- Đánh dấu các trang web có hướng dẫn lâm sàng để thúc đẩy truy xuất thông tin nhanh hơn - Đánh giá sự có sẵn của các thiết bị công nghệ (ví dụ như PDA – thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân) để tạo ra các hệ thống tiết kiệm thời gian cho phép truy xuất thông tin nhanh chóng và thuận tiện ngay tại giường bệnh. - Thương lượng thời gian thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân giữa đồng nghiệp với nhau để thu thập, đọc và chia sẻ thông tin về các vấn đề lâm sàng liên quan. - Tìm kiếm những hướng dẫn thực hành lâm sàng đã có sẵn bởi vì những hướng dẫn này cung cấp một cách tổng hợp các nghiên cứu hiện có.
Nghiên cứu trong thực tế không được xem trọng	- Liệt kê một danh sách những lí do tại sao nhân viên y tế nên xem trọng giá trị nghiên cứu, và sử dụng danh sách này như là một bàn đạp để thảo luận với các đồng nghiệp. - Mời các nhà nghiên cứu điều dưỡng để chia sẻ tại sao lại say mê công việc này. - Khi bất đồng nảy sinh về một chính sách hoặc phương thức thực hiện, hãy tìm một bài báo ủng hộ quan điểm và chia sẻ nó với những người khác. - Khi chọn lựa một môi trường làm việc, hãy hỏi về cam kết của tổ chức đó đối với việc thực hiện EBP. - Liên kết việc đo lường các chỉ số chất lượng với EBP. - Tham gia vào các hoạt động EBP để thể hiện tính chuyên nghiệp có thể nhận được giải thưởng thông qua các chương trình khuyến khích hoặc nâng cao thành tích. - Cung cấp sự công nhận trong tuần lễ điều dưỡng quốc gia cho các cá nhân tham gia vào các dự án EBP.
Thiếu kiến thức về thực hành dựa trên bằng chứng và nghiên cứu	- Tham gia vào các khóa học đào tạo liên tục về thực hành dựa trên bằng chứng. - Mời giảng viên/chuyên gia tham gia vào cuộc họp với đơn vị để thảo luận về thực hành dựa trên bằng chứng. - Tham khảo ý kiến của các điều dưỡng có kinh nghiệm thực hành nâng cao. - Tham dự các hội thảo nơi mà các nghiên cứu lâm sàng được trình bày - Tình nguyện tham gia phục vụ trong các ủy ban xây dựng chính sách và định hướng thực hiện.

	- Tạo một chương trình cố vấn để tập hợp các điều dưỡng mới và điều dưỡng có kinh nghiệm trao đổi với nhau.
Thiếu kĩ năng công nghệ để tìm kiếm bằng chứng	- Tham khảo các thư viện viên về cách làm thế nào để tiếp cận nguồn dữ liệu và lấy bài báo. - Học cách đánh dấu những websites quan trọng – những trang web là nguồn tài nguyên của hướng dẫn lâm sàng. - Cam kết đạt được kĩ năng vi tính.
Thiếu nguồn tài nguyên để tiếp cận bằng chứng	- Viết đề xuất nguồn quỹ hỗ trợ để truy cập vào nguồn dữ liệu trực tuyến. - Cộng tác với một chương trình điều dưỡng để tiếp cận các nguồn tài nguyên. - Khảo sát khả năng tài trợ từ những nguồn khác (ví dụ như công ty dược, quỹ trợ cấp).
Thiếu khả năng đọc nghiên cứu	- Tổ chức câu lạc bộ tạp chí nơi mà các điều dưỡng viên gặp nhau thường xuyên để thảo luận các bằng chứng về một vấn đề lâm sàng đặc biệt. - Viết ra câu hỏi về một bài báo và hỏi điều dưỡng có kinh nghiệm thực hành nâng cao để đọc bài báo và trả lời câu hỏi. - Làm rõ các thuật ngữ không quen thuộc bằng cách tra cứu chúng trong từ điển hoặc giao trình nghiên cứu. - Sử dụng một mẫu phân tích quen thuộc khi đọc nghiên cứu. - Xác định vấn đề lâm sàng và chia sẻ chúng với các nhà nghiên cứu điều dưỡng - Tham gia vào các nghiên cứu dựa trên đơn vị đang thực hiện. - Đăng ký các tạp chí cung cấp giải thích không phức tạp về các nghiên cứu.
Không chịu thay đổi	- Lắng nghe mối quan tâm của mọi người về sự thay đổi. - Khi xem xét một dự án EBP, hãy chọn một dự án mà nhân viên quan tâm, có mức độ ưu tiên cao, có khả năng thành công và có dữ liệu cơ sở. - Huy động các cá nhân tài năng làm tác nhân thay đổi. - Xây dựng phong trào để khen thưởng những cá nhân lãnh đạo trong quá trình thay đổi.
Tổ chức không chấp nhận thực hành dựa trên bằng chứng	- Liên kết các ưu tiên của tổ chức với EBP để giảm chi phí và tăng hiệu quả - Tuyển dụng người quản lý xem trọng EBP - Liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác để tăng cơ sở hỗ trợ cho EBP

	- Sử dụng EBP để đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận hoặc đạt được sự công nhận (VD: Magnet Recognition)

1.9. Các bước EBP

a. Bước 0: Nuôi dưỡng tinh thần học hỏi trong môi trường và văn hóa EBP

Trước khi bắt tay vào các bước được sử dụng phổ biến của EBP, điều quan trọng là phải nuôi dưỡng tinh thần học hỏi (VD: thái độ luôn đặt câu hỏi trong thực hành) để nhân viên y tế cảm thấy thoải mái và hào hứng khi đặt câu hỏi liên quan đến chăm sóc người bệnh cũng như yêu cầu thực hành dựa trên thể chế hiện hành.

Nếu không có văn hóa và môi trường hỗ trợ tinh thần học hỏi và EBP, các nỗ lực thay đổi EBP của cá nhân và tổ chức sẽ gần như không thể thành công và duy trì (Melnyk, 2016a). Văn hóa khuyến khích EBP sẽ thúc đẩy tinh thần học hỏi này và giúp nhân viên y tế có thể nhận thức được bằng cách đưa nó vào triết lý và sứ mệnh của tổ chức.

Các yếu tố chính của môi trường và văn hóa EBP bao gồm:

- Một tinh thần học hỏi trong đó tất cả các nhân viên y tế được khuyến khích đặt câu hỏi về thực hành hiện tại;
- Một triết lý, sứ mệnh, hệ thống thúc đẩy lâm sàng và quy trình đánh giá kết hợp EBP và năng lực EBP;
- Đội ngũ cố vấn EBP, những người có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về EBP, cố vấn cho những người khác vượt qua các rào cản đối với sự thay đổi của cá nhân và tổ chức;
- Cơ sở hạ tầng cung cấp các công cụ để nâng cao EBP (ví dụ: máy tính để tìm kiếm tại nơi chăm sóc, tiếp cận cơ sở dữ liệu chính và nhân viên thư viện, các buổi xây dựng kỹ năng và giáo dục EBP đang diễn ra, phạm vi EBP và câu lạc bộ tạp chí);
- Hỗ trợ hành chính và lãnh đạo đánh giá giá trị và mô hình hóa EBP cũng như cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì EBP ;
- Thường xuyên ghi nhận các cá nhân và nhóm thực hiện EBP một cách nhất quán.

b. Bước 1: Hình thành câu hỏi PICOT cấp thiết về lâm sàng

Trong bước 1 của EBP, các câu hỏi lâm sàng được đặt ra ở định dạng PICOT (VD: đối tượng người bệnh, can thiệp hoặc vấn đề quan tâm, nhóm hoặc can thiệp so sánh, kết quả và khung thời gian) để mang lại bằng chứng phù hợp nhất và tốt nhất từ việc tìm kiếm y văn. Ví dụ, một câu hỏi PICOT được thiết kế tốt sẽ như sau: Ở thanh thiếu niên (*đối tượng người bệnh*), việc xây dựng kỹ năng hành vi nhận thức (*can thiệp thử nghiệm*) so với yoga (*can thiệp so sánh*) ảnh hưởng như thế nào đến lo âu (*kết quả*) sau 6 tuần điều trị (*thời gian thực hiện để các can thiệp đạt được kết quả*)?.

Các câu hỏi đặt ra ở định dạng PICOT giúp tìm kiếm hiệu quả mang lại thông tin tốt nhất, phù hợp và tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể (Melnyk & Fineout-Overholt, 2015). Ngược lại, một câu hỏi không phù hợp (ví dụ: Loại can thiệp tốt nhất đối với tình trạng lo âu của thanh thiếu niên là gì?) Sẽ dẫn đến một tìm kiếm không tập trung và kết quả có thể bao gồm hàng trăm bản tóm tắt không thể sử dụng và thông tin không liên quan.

Đối với các câu hỏi lâm sàng khác không tập trung vào can thiệp, có thể dùng từ với ý nghĩa là "vấn đề quan tâm" thay vì "can thiệp". Ví dụ về câu hỏi PICOT không can thiệp như sau: Các bà mẹ mới sinh *(đối tượng người bệnh)* bị các biến chứng liên quan đến vú *(vấn đề được quan tâm)* nhận thức như thế nào về khả năng cho con bú *(kết quả)* trong 3 tháng đầu sau khi sinh *(khung thời gian của vấn đề nhận thức)?* Trong câu hỏi này, không có nhóm so sánh thích hợp, vì vậy PIOT là phù hợp; tuy nhiên, nó vẫn được coi là một câu hỏi PICOT.

Khi một vấn đề lâm sàng tạo ra nhiều câu hỏi lâm sàng, nên ưu tiên cho những câu hỏi có kết quả quan trọng nhất hoặc xảy ra thường xuyên nhất (tức là những vấn đề lâm sàng xảy ra với tần suất lớn và/hoặc những vấn đề có nguy cơ cao dẫn đến kết quả tiêu cực cho người bệnh). Ví dụ, điều dưỡng và bác sĩ khoa ngoại thường gặp câu hỏi, "Ở người bệnh sau mổ, morphin và hydromorphone khác nhau như thế nào trong việc giảm đau ở nửa giờ sử dụng đầu tiên?" Một câu hỏi khác có thể là "Về vận động ở người bệnh sau mổ, khác biệt giữa đi bộ hàng ngày so với không đi bộ hàng ngày trong việc ngăn ngừa loét do tì đè trong thời gian nằm viện như thế nào?"

Vấn đề lâm sàng ưu tiên là trả lời câu hỏi giảm đau vì đau là vấn đề xảy ra hàng ngày ở đối tượng này, thay vì ưu tiên tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi thứ hai vì loét tì đè hiếm khi xảy ra ở người bệnh sau phẫu thuật.

c. Bước 2: Tìm kiếm bằng chứng tốt nhất

Việc tìm kiếm bằng chứng tốt nhất trước tiên nên bắt đầu bằng cách xem xét các thành phần của câu hỏi PICOT. Mỗi từ khóa trong câu hỏi PICOT nên được sử dụng để bắt đầu tìm kiếm có hệ thống.

Loại nghiên cứu cung cấp câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi can thiệp hoặc điều trị là các bài tổng quan hệ thống hoặc các bài phân tích gộp, được xem là cấp bằng chứng mạnh nhất để làm cơ sở cho các quyết định điều trị (tức là mức độ I) (Melnyk & Fineout- Overholt, 2015). Có các mức độ bằng chứng khác nhau cho từng loại câu hỏi PICOT (xem phần bàn luận sâu hơn ở chương 2). Mặc dù có nhiều phân loại bằng chứng trong y văn để trả lời các câu hỏi PICOT can thiệp, chúng tôi chọn trình bày một hệ thống phân loại bằng chứng để giải quyết các câu hỏi với nhiều bằng chứng, bao gồm các tổng quan hệ thống về bằng chứng định tính, còn được gọi là phân tích gộp.

d. Bước 3: Đánh giá phân tích bằng chứng

Bước 3 trong quy trình EBP quan trọng ở chỗ nó liên quan đến việc đánh giá phân tích các bằng chứng thu được từ quá trình tìm kiếm. Mặc dù các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể xem đánh giá là một quá trình đánh giá toàn diện và tốn nhiều thời gian, các bước đầu tiên của việc đánh giá có thể thực hiện một cách hiệu quả bằng cách trả lời ba câu hỏi chính như một phần của quá trình đánh giá nhanh, trong đó các nghiên cứu được đánh giá về tính giá trị, độ tin cậy, và khả năng sử dụng để trả lời câu hỏi lâm sàng đã đặt ra:

- Kết quả của nghiên cứu có giá trị không? (Tính giá trị): Các kết quả có chân thực không? Các nhà nghiên cứu có thực hiện nghiên cứu bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu tốt nhất có thể không? Ví dụ, trong các thử nghiệm can thiệp, điều quan trọng là phải xác định xem các đối tượng có được chia **ngẫu nhiên** vào nhóm điều trị hay nhóm chứng không, và liệu họ có bình đẳng về các đặc điểm chính trước khi điều trị hay không.

- Kết quả là gì? (Độ tin cậy) Ví dụ, trong một thử nghiệm can thiệp, độ tin cậy gồm (a) can thiệp có hiệu quả hay không; (b) hiệu quả điều trị đạt tới mức nào; và (c) các nhà lâm sàng có mong muốn kết quả tương tự hay không nếu họ thực hiện can thiệp trong bối cảnh của họ (tức là mức độ chính xác của hiệu quả can thiệp). Trong các nghiên cứu định tính, độ tin cậy bao gồm việc đánh giá xem phương pháp tiếp cận có phù hợp với mục đích của nghiên cứu hay không, cùng với việc đánh giá các khía cạnh khác của nghiên cứu.

- Kết quả có giúp ích cho tôi trong việc chăm sóc người bệnh không? (Khả năng áp dụng) Câu hỏi thứ 3 để đánh giá nhanh là (a) các đối tượng trong nghiên cứu có giống với những người bệnh đang được chăm sóc hay không; (b) lợi ích có lớn hơn nguy cơ của việc điều trị không (tức là có khả năng gây hại); (c) việc điều trị có khả thi trong thực hành không; và (d) người bệnh có mong muốn được điều trị không.

e. Bước 4: Tích hợp bằng chứng với chuyên môn lâm sàng và người bệnh/gia đình

Ưu tiên đưa ra quyết định lâm sàng tốt nhất. Bước quan trọng tiếp theo trong EBP là tích hợp bằng chứng tốt nhất được tìm thấy từ y văn với chuyên môn của nhân viên y tế và mong muốn và giá trị của người bệnh/gia đình để đưa ra quyết định (tức là đưa bằng chứng vào hành động).

Chuyên môn lâm sàng bao gồm cách các nhà lâm sàng hiểu về đối tượng người bệnh mà họ chăm sóc và các di chứng đã biết về lâm sàng, các nguồn lực chăm sóc sức khỏe sẵn có, kinh nghiệm cá nhân trong việc ra quyết định chăm sóc và năng lực đánh giá phân tích. Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ y tế muốn tham gia vào quá trình đưa ra quyết định lâm sàng và trách nhiệm đạo đức của nhà cung cấp dịch vụ y tế là để người bệnh tham gia vào các quyết định điều trị.

Ngay cả khi bằng chứng từ một cuộc tìm kiếm nghiêm túc và đánh giá kỹ lưỡng cho thấy rõ rằng phương pháp điều trị là có lợi (ví dụ: liệu pháp thay thế hormone [HRT] để ngăn ngừa loãng xương ở phụ nữ có nguy cơ rất cao), thảo luận với người bệnh có thể thấy được nỗi lo sợ của họ với việc tăng nguy cơ ung thư vú khi dùng HRT hoặc các lý do khác khiến họ không chấp nhận điều trị. Hơn nữa, khi khai thác bệnh sử hoặc khám sức khỏe, có thể phát hiện bệnh kèm theo hoặc chống chỉ định làm tăng nguy cơ mắc HRT (ví dụ: tiền sử đột quỵ).

Do đó, mặc dù có bằng chứng thuyết phục ủng hộ lợi ích của HRT trong việc ngăn ngừa loãng xương ở phụ nữ có nguy cơ cao, nhưng quyết định không sử dụng có thể được đưa ra sau khi đánh giá kỹ lưỡng từng người bệnh và thảo luận về rủi ro và lợi ích của việc điều trị.

f. Bước 5: Đánh giá kết quả của việc thay đổi thực hành dựa trên bằng chứng

Bước 5 trong EBP là đánh giá sáng kiến dựa trên bằng chứng về việc các thay đổi ảnh hưởng đến kết quả của người bệnh như thế nào hoặc mức độ hiệu quả của quyết định lâm sàng trên người bệnh cụ thể hoặc cơ sở thực hành. Loại đánh giá này là cần thiết để xác định xem liệu sự thay đổi dựa trên bằng chứng có dẫn đến kết quả mong đợi khi được thực hiện trong thực tế lâm sàng hay không. Đo lường kết quả, đặc biệt là những kết quả quan trọng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày nay (ví dụ: thời gian nằm viện, tỷ lệ tái nhập viện, biến chứng, thay đổi nhân sự, chi phí), là điều quan trọng để xác định và ghi nhận tác động của sự thay đổi EBP dối với chất lượng chăm sóc sức khỏe và/hoặc kết quả của người bệnh (Melnyk & Morrison- Beedy, 2012).

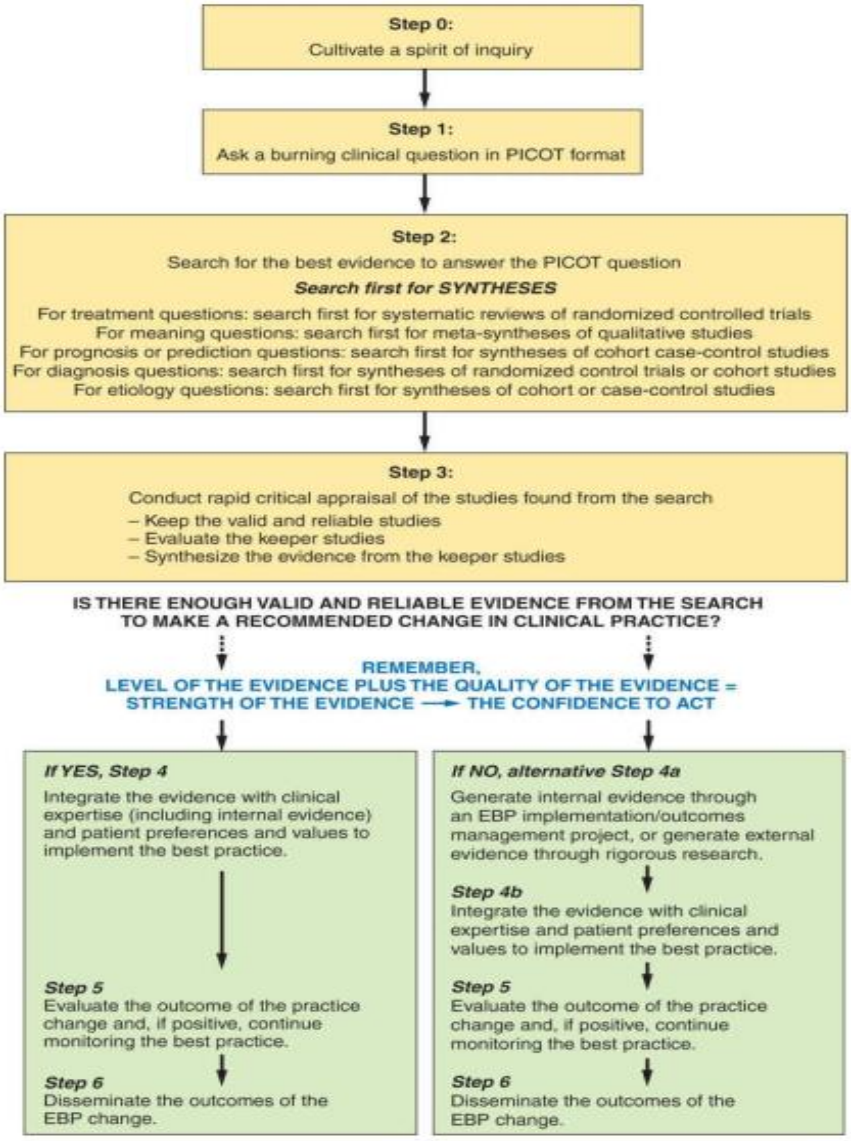
Nếu một thay đổi trong thực hành dựa trên bằng chứng không tạo ra những kết quả như đã chứng minh trong một nghiên cứu chặt chẽ, các nhà lâm sàng nên tự đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau (Liệu can thiệp có được thực hiện theo đúng cách mà nó đã được thực hiện trong nghiên cứu không? Liệu bối cảnh lâm sàng có tương tự như trong các nghiên cứu?).

g. Bước 6: Phổ biến kết quả của thay đổi thực hành dựa trên bằng chứng

Bước cuối cùng trong EBP là phổ biến kết quả của thay đổi EBP. Thông thường, các nhà lâm sàng đạt được nhiều kết quả tích cực thông qua những thay đổi trong chăm sóc dựa trên bằng chứng, nhưng những kết quả đó không được chia sẻ cho những người khác, ngay cả đồng nghiệp trong cùng cơ quan của họ. Kết quả là, những người khác không được học kết quả cũng như quá trình đưa đến kết quả đó, và các nhà lâm sàng cũng như người bệnh ở các cơ sở khác không được hưởng lợi từ kiến thức đó.

Điều quan trọng là các nhà lâm sàng phải phổ biến kết quả của những thay đổi trong thực hành dựa trên bằng chứng thông qua các phương pháp như thuyết trình và áp phích tại

các hội nghị tại địa phương, khu vực và quốc gia; EBP dạo quanh các tổ chức; các ấn phẩm.



Hình 1. Các bước của thực hành dựa trên bằng chứng

Nguồn : Bernadette Mazurek Melnyk (2019)

CHƯƠNG II.
NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƯỠNG VÀ THỰC HÀNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

1. Nghiên cứu Điều dưỡng là gì?

Nghiên cứu là một hoạt động có kế hoạch và có hệ thống nhằm cung cấp kiến thức mới và/hoặc khám phá ra giải pháp cho các vấn đề hoặc câu hỏi (Polit & Beck, 2004). Nói một cách đơn giản, nghiên cứu có nghĩa là tìm kiếm lại. Nhưng việc tìm kiếm phải được cân nhắc và có tổ chức khi các câu hỏi liên quan được kiểm tra. Điều cần thiết là phải tuân theo các bước đã thiết lập.

Điều dưỡng sử dụng nghiên cứu để tạo ra kiến thức mới hoặc xác nhận và tinh chỉnh kiến thức hiện có sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến thực hành chăm sóc. Trong nghiên cứu điều dưỡng, các đối tượng được quan tâm là con người, sức khỏe, điều dưỡng và môi trường. Điều dưỡng nghiên cứu kết quả chăm sóc người bệnh, thái độ của điều dưỡng, hiệu quả của chính sách và chiến lược giảng dạy trong đào tạo điều dưỡng.

Làm theo cách tiếp cận có hệ thống có thể mang lại kết quả tin cậy để sử dụng. Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhằm mục đích mô tả, giải thích và dự đoán các hiện tượng. Nhưng không phải khoa học phải chứng minh những điều đó là sự thật? Đôi khi chúng ta có thể nghe thấy cụm từ "nghiên cứu chứng minh" bởi những nhà khoa học khác hoặc trên các phương tiện truyền thông; tuy nhiên, việc sử dụng từ "chứng minh" là không chính xác. Kết quả nghiên cứu "ủng hộ" một cách tiếp cận hoặc quan điểm cụ thể, bởi vì khả năng sai sót tồn tại trong mọi nghiên cứu. Điều này nhấn mạnh tại sao một cách tiếp cận có kế hoạch, có hệ thống là cần thiết và tại sao các nghiên cứu nhân rộng lại quan trọng.

Nghiên cứu điều dưỡng góp phần phát triển và hoàn thiện lý thuyết. Nhưng quan trọng nhất, nếu là điều dưỡng sắp tốt nghiệp, bạn sẽ sử dụng nghiên cứu làm nền tảng cho EBP. Nếu không có nghiên cứu, thực hành điều dưỡng sẽ dựa trên truyền thống, thẩm quyền, thử nghiệm và sai sót, kinh nghiệm cá nhân, trực giác, và bằng chứng vay mượn. Đây là lý do tại sao bạn phải có kỹ năng đọc, đánh giá và áp dụng nghiên cứu điều dưỡng để khi là người sớm áp dụng, bạn có thể áp dụng điều mới vào việc chăm sóc.

Bảng 2.1. Các bước của quá trình nghiên cứu

1. Xác định câu hỏi nghiên cứu
2. Tiến hành làm tổng quan tài liệu
3. Xác định khung học thuyết
4. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu
5. Thực hiện nghiên cứu

Nội dung được thiết kế và xây dựng bởi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

6. Xử lý số liệu
7. Rút ra kết luận
8. Công bố kết quả

2. Các loại nghiên cứu

Có nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả nghiên cứu do các nhà khoa học thực hiện. Nghiên cứu có thể được phân loại là mô tả, giải thích hoặc dự đoán; cơ bản hoặc ứng dụng; và định lượng hoặc định tính. Các phân loại này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Ví dụ, một nghiên cứu có thể mang tính mô tả, ứng dụng và định tính. Mặc dù điều này có vẻ rất phức tạp, nhưng khi hiểu các định nghĩa, nó sẽ trở nên rõ ràng.

Một cách để phân loại nghiên cứu là theo mục đích của nó. Nghiên cứu mô tả trả lời câu hỏi, "Nó là gì?" Loại nghiên cứu này quan tâm đến việc cung cấp các mô tả chính xác và có thể liên quan đến việc quan sát một hiện tượng trong bối cảnh tự nhiên. Mục tiêu của loại nghiên cứu giải thích là xác định các mối quan hệ của đối tượng với cá nhân, nhóm, tình huống hoặc sự kiện. Các nghiên cứu giải thích lý giải các hiện tượng "tại sao " hoặc "như thế nào" có liên quan với nhau. Nghiên cứu dự đoán nhằm dự báo các mối quan hệ chính xác giữa các phương diện của hiện tượng hoặc sự khác biệt giữa các nhóm. Loại nghiên cứu này lý giải "khi nào" các hiện tượng sẽ xảy ra.

Một cách khác để phân loại nghiên cứu là xem xét liệu các phát hiện có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tế hay không. Nghiên cứu cơ bản nhằm tìm kiếm kiến thức vì lợi ích mang lại từ những kiến thức đó. Kiến thức này có thể hoặc không thể áp dụng vào thực tế. Có thể mất nhiều năm trước khi một khám phá trở nên hữu ích khi nó được kết hợp với những khám phá khác.

Ví dụ, vitamin K được nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thêm về các đặc tính của nó. Nhiều năm sau, kiến thức thu được về cơ chế hoạt động của nó trong quá trình đông máu đã tạo nền tảng cho vitamin K trở thành một phương pháp điều trị được chấp nhận cho các rối loạn chảy máu. Ngược lại, mục đích của nghiên cứu ứng dụng là tìm ra kiến thức để giải quyết một vấn đề lâm sàng.

Các kết quả thường có ứng dụng ngay lập tức để mang lại những thay đổi trong thực hành, giáo dục hoặc quản lý. Định lượng và định tính là những thuật ngữ cũng được sử dụng để phân biệt các loại hình nghiên cứu. Triết lý, câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và số liệu đều để giúp phân biệt giữa hai phương pháp phân loại này. Nghiên cứu định lượng xem thế giới là khách quan. Điều này ngụ ý rằng các nhà nghiên cứu có thể tách mình ra khỏi các hiện tượng đang được nghiên cứu. Tập trung thu thập bằng chứng thực nghiệm, hay nói cách khác là bằng chứng được thu thập thông qua năm giác quan. Các nhà nghiên cứu định lượng các quan sát bằng cách sử dụng các con số để có được các phép đo chính xác để phân tích

thống kê sau đó. Nhiều nghiên cứu định lượng kiểm tra các giả thuyết. Ngược lại, tiền đề của nghiên cứu định tính là thế giới không khách quan. Có thể có nhiều hiện thực vì bối cảnh của mỗi người khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian. Một điểm quan trọng khác về phương pháp định lượng và định tính là đi kèm với hai cách lập luận khác nhau. Lập luận suy luận, chủ yếu gắn liền với nghiên cứu định lượng, là lý luận đi từ cái chung đến cái riêng.

3. Đọc bài báo nghiên cứu

*** Mục tiêu khi đọc bài báonghiên cứu**

1. Xác định mục đích nghiên cứu
2. Hiểu cách nghiên cứu được thực hiện
3. Hiểu về kết quả nghiên cứu
4. Đánh giá độ tin cậy của kết quả
5. Xác định xem các kết quả có liên quan đến việc chăm sóc người bệnh không.

*** Mẫu báo cáo nghiên cứu**

Sự phát triển của EBP đòi hỏi sự tập trung chú ý vào các nghiên cứu đã được công bố. Do đó, điều dưỡng cần phải xác định các nghiên cứu từ các loại bài báo trong y văn. Bí quyết là phải biết về các phần trong một bài báo nghiên cứu.

Thông thường, phần tóm tắt (Abstract) là phần đầu tiên của một bài báo nghiên cứu và thường được giới hạn trong 100–150 từ. Mục đích của tóm tắt là cung cấp một cái nhìn tổng quan về nghiên cứu, nhưng sự hiện diện của một tóm tắt không nhất thiết có nghĩa là nó là một bài báo nghiên cứu. Vì thường có các bài tóm tắt trên các trang báo trực tuyến, việc đọc chúng trước khi in hoặc xin một bản sao của bài báo thường rất hữu ích. Tập trung chú ý vào phần tóm tắt có thể tránh lãng phí thời gian và công sức cho các bài báo không áp dụng được cho câu hỏi lâm sàng.

Phần mở đầu (Introduction), theo sau phần tóm tắt, bao gồm nêu vấn đề và mục đích nghiên cứu. Nêu vấn đề là xác định vấn đề một cách chung chung và bao quát. Ví dụ, phần đặt vấn đề có thể là, "bệnh nhân té ngã khi nằm viện có thể làm tăng thời gian nằm viện." Các tác giả thường cung cấp thông tin cơ bản và số liệu thống kê về vấn đề để thuyết phục người đọc rằng vấn đề đó là quan trọng. Thông tin chung nên tạo tiền đề cho việc nêu mục đích mô tả những gì đã được điều tra trong nghiên cứu. Ví dụ, phần nêu mục đích nghiên cứu có thể là, "mục đích của nghiên cứu này là để xem xét mối quan hệ giữa thời gian dùng thuốc buổi tối và thời gian té ngã." Một phần giới thiệu tốt sẽ thuyết phục người đọc rằng nghiên cứu đáng được tiến hành.

Phần thứ ba là tổng quan tài liệu (Review of literature). Cần trình bày một bản mô tả tổng hợp, toàn diện, không thiên vị về các nghiên cứu có liên quan, đã được công bố trước đó. Tổng

quan bàn luận về mục đích, cỡ mẫu, thiết kế nghiên cứu và kết quả quan trọng cho mỗi nghiên cứu. Tổng quan nên tập trung vào những công trình gần đây nhất về lĩnh vực nhưng cũng có thể bao gồm các trích dẫn cũ hơn nếu chúng được xem là các nghiên cứu mang tính bước ngoặt. Mỗi bài báo có trích dẫn đầy đủ để độc giả có thể tìm nếu muốn. Một tổng quan tài liệu tốt sẽ kết luận với phần tóm tắt những gì đã biết về vấn đề và xác định những lỗ hổng trong cơ sở kiến thức để cho người đọc thấy nghiên cứu sẽ bổ sung kiến thức hiện có như thế nào.

Trong bài báo nghiên cứu cần có phần bàn luận (discussion) về khung học thuyết, có thể là một phần riêng hoặc kết hợp với tổng quan tài liệu. Khung học thuyết thường mô tả mối quan hệ giữa các khái niệm chung và cung cấp mối liên hệ với những gì đang được đo lường trong nghiên cứu. Các tác giả thường sử dụng một mô hình hoặc sơ đồ để giải thích khung học thuyết. Phần chính của bài báo nghiên cứu là phần phương pháp, bao gồm thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu và thu thập số liệu. Trong hầu hết các trường hợp, các tác giả sẽ mô tả rõ loại thiết kế dùng để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Trong phần này, điều quan trọng là các tác giả phải mô tả dân số mục tiêu và giải thích cách thu thập được mẫu. Cần nêu các quy trình, phương pháp thu thập số liệu. Trong suốt phần này, các tác giả sẽ cung cấp cơ sở lý luận liên quan đến việc quyết định cách thức thực hiện nghiên cứu.

Phần kết quả thường được xem là khó hiểu nhất. Ở đây, các tác giả mô tả phương pháp sử dụng để phân tích số liệu và báo cáo các đặc điểm của mẫu. Trong các nghiên cứu định lượng, các bảng số liệu thường được đưa vào để giải thích, và các tác giả chỉ ra kết quả nào là quan trọng hay không quan trọng. Trong các nghiên cứu định tính, các chủ đề được hỗ trợ bởi các trích dẫn từ những người tham gia. Sau khi đọc phần kết quả, người đọc cần tin rằng các nhà nghiên cứu đã chọn phương pháp phân tích phù hợp với số liệu đã thu thập.

Phần nội dung của một bài báo nghiên cứu kết thúc bằng phần thảo luận (discussion). Các tác giả giải thích các kết quả và bàn luận về cách các kết quả đóng góp vào kiến thức. Kết quả phải gắn kết với tổng quan tài liệu và khung học thuyết. Các hạn chế của thiết kế nghiên cứu cũng được bàn luận, và đôi khi các giải pháp khả thi được đề xuất để giải quyết trong các nghiên cứu về sau.

Các gợi ý về thực hành, nghiên cứu và giáo dục cũng được đề xuất. Thông thường, sẽ rất hữu ích nếu đọc phần này sau khi đọc phần tóm tắt và phần giới thiệu vì nó nêu rõ lý do cho những nội dung tiếp theo. Bài báo kết thúc với danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài báo.

Trong khi có các hình thức khác nhau, nhiều tạp chí tuân thủ các hướng dẫn từ Hiệp hội Tâm lý học Mỹ. Vì việc tham khảo các tài liệu trong phần tài liệu tham khảo thường là hữu

ích, nên tốt nhất là tìm một bản đầy đủ toàn bộ bài báo, bao gồm cả danh mục tài liệu tham khảo.

4. Tìm bằng chứng ở đâu?

Khi vào bất kỳ cổng thông tin nào, quyết định nơi bắt đầu tìm bằng chứng cho câu hỏi lâm sàng là rất quan trọng. Điều quan trọng là tránh sai lệch trong quá trình tìm kiếm, việc truy xuất tài liệu bị sai lệch hoặc không đầy đủ là kết quả của việc tìm kiếm bất cẩn hoặc không đầy đủ hoặc lựa chọn sai cơ sở dữ liệu. Kiến thức về phạm vi, đặc điểm chuyên biệt và chức năng của bất kỳ cơ sở dữ liệu trực tuyến nào là rất quan trọng đối với việc tìm kiếm tài liệu.

Tổng quan tài liệu chặt chẽ, toàn diện, rõ ràng là những yêu cầu trong bảng đánh giá. Hiểu biết về quá trình tạo thông tin (ACRL, 2015), bình duyệt, phương pháp nghiên cứu và quy trình xuất bản đều cần thiết khi quyết định nơi để tìm kiếm và xác định "bằng chứng."

Tại sao không Google?

Khi bắt tay vào tìm kiếm bằng chứng, bạn có thể đặt ra câu hỏi, Google thì sao? Các công cụ tìm kiếm như Google, Google Scholar hoặc một công cụ quy mô như website thương mại được cấp phép có thể hữu ích như một bước đầu tiên mang tính hướng dẫn để mở rộng chiến lược nhằm:

- Đắm mình trong một chủ đề mới,
- Xác định một "mục đã biết" (một bài báo của một tác giả nhất định, trong một năm nhất định, trên một tạp chí chuyên biệt),
- Hiểu được chiều rộng hoặc chiều sâu của một chủ đề,
- Xác định bằng chứng được trích dẫn nhiều trong tài liệu, và
- Bắt đầu thấy sự mơ hồ được trong một từ khóa tìm kiếm đơn giản, xác định các từ đồng nghĩa và nhận thức được "lượt truy cập sai.

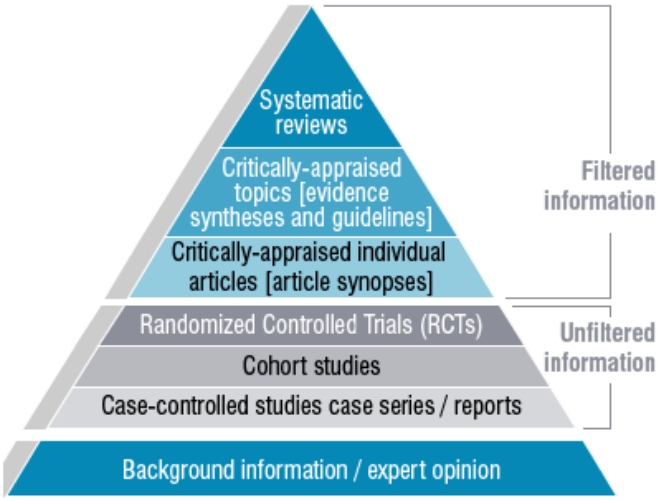
Tuy nhiên, một cạm bẫy của một công cụ trên quy mô web lớn là người tìm kiếm thường tìm thấy lượt truy cập lớn và không thể quản lý được. Các công cụ tìm kiếm có chỉ mục "web", thường che giấu những thứ miễn phí và những thứ ẩn sau mức phí của nơi truy cập. Các công cụ quy mô web có thể che giấu sự khác biệt giữa học bổng và nội dung "do người dùng tạo" (Knapp & Brower, 2014), được xếp hạng bởi một thuật toán không xác định có thể nghiêng về nội dung được quảng cáo.

Kết quả cho một tìm kiếm từ khóa điển hình thường rất rộng và không sàng lọc. Đối với hầu hết các chủ đề liên quan đến nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe, kết quả có quá

nhiều, khiến bạn phải chọn ngẫu nhiên các kết quả từ đầu một danh sách dài. Để hiểu được môi trường số hóa thì quan trọng là sự khám phá.

5. Phân cấp bằng chứng

Hệ thống phân cấp EBP xếp hạng các loại nghiên cứu dựa trên mức độ nghiêm ngặt (sức mạnh và độ chính xác) của các phương pháp nghiên cứu của chúng. Các phân cấp khác nhau tồn tại cho các loại câu hỏi khác nhau và thậm chí các chuyên gia có thể không đồng ý về thứ hạng chính xác của thông tin trong phân cấp bằng chứng. Hình sau đại diện cho hệ thống phân cấp bằng chứng của Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia Úc NHMRC.



Hình 2. Phân cấp bằng chứng

Nguồn: Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia (NHMRC) (Hoa Kỳ) (2015)

Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng thiết kế nghiên cứu có phân cấp càng cao thì phương pháp lý luận càng chặt chẽ và do đó càng có nhiều khả năng thiết kế nghiên cứu có thể giảm thiểu ảnh hưởng của sự sai lệch đối với kết quả nghiên cứu. Trong hầu hết các phân cấp bằng chứng hiện tại, các tổng quan hệ thống và phân tích gộp được thiết kế tốt nằm ở trên cùng của tháp, còn ý kiến chuyên gia và kinh nghiệm nằm ở phía dưới.

Bảng 2.2. Phân cấp bằng chứng

Mức độ bằng chứng (LOE)	Mô tả

Cấp I	Bằng chứng từ việc xem xét các bài tổng quan hệ thống hoặc phân tích gộp được tổng hợp từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng (RCT) có liên quan hoặc các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng dựa trên các đánh giá có hệ thống về RCT hoặc ba hoặc nhiều RCT có chất lượng tốt có kết quả tương tự.
Cấp II	Bằng chứng thu được từ ít nhất một RCT được thiết kế tốt (ví dụ: RCT với cỡ mẫu lớn).
Cấp III	Bằng chứng thu được từ các thử nghiệm đối chứng được thiết kế tốt mà không có ngẫu nhiên (tức là bán thực nghiệm).
Cấp IV	Bằng chứng từ các nghiên cứu thuần tập hoặc bệnh chứng được thiết kế tốt.
Cấp độ V	Bằng chứng từ các đánh giá có hệ thống về các nghiên cứu mô tả và định tính (tổng hợp tổng hợp).
Cấp độ VI	Bằng chứng từ một nghiên cứu mô tả hoặc định tính.
Cấp độ VII	Bằng chứng từ ý kiến của cơ quan chức năng và / hoặc báo cáo của các ủy ban chuyên môn.

6. Quy trình phát triển EBP và các câu hỏi trong các bối cảnh lâm sàng khác nhau

Cho dù là điều dưỡng thực hành, chuyên gia lâm sàng, lãnh đạo điều dưỡng lâm sàng, giảng viên điều dưỡng, người quản lý điều dưỡng hoặc thành viên của nhóm cải tiến chất lượng tại cơ quan y tế, bạn đều là một nhà lãnh đạo lâm sàng. Thực hành dựa trên bằng chứng (EBP) là một thành phần quan trọng trong chuyên môn của bạn đối với người bệnh và nhân viên của mình.

EBP cung cấp nền tảng để phát triển các câu hỏi lâm sàng khởi động tìm kiếm thông tin sức khỏe để cung cấp bằng chứng tốt nhất cho các quyết định chăm sóc sức khỏe và lâm sàng. Dịch vụ chăm sóc tiết kiệm, chất lượng cao mang lại trải nghiệm hài lòng cho người bệnh, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên thúc đẩy các chuyên gia y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng mới nhất và tốt nhất (Berwick và cộng sự, 2008). Môi trường chăm sóc bên ngoài — bao gồm, nhưng không giới hạn ở người bệnh, người sử dụng lao động, tổ chức chứng nhận, hội đồng quản lý, công ty bảo hiểm và tổ chức nghề nghiệp ngày càng mong rằng thông tin dựa trên bằng chứng định hướng thực hành lâm sàng. Thực hành lâm sàng luôn được cập nhật bằng cách tìm kiếm, truy xuất và đánh giá nghiêm túc các nghiên cứu, tổng quan hệ

thống và hướng dẫn EBP áp dụng cho các vấn đề thực tế trong môi trường lâm sàng. Các nhà lâm sàng cố gắng điều hướng sự phong phú của thông tin lâm sàng có sẵn cho các chuyên gia y tế; tìm kiếm đúng thông tin, vào đúng thời điểm, sử dụng đúng phương pháp tìm kiếm là một thách thức!

CHƯƠNG III.
CÂU HỎI THỰC HÀNH

1. Câu hỏi lâm sàng là gì?

a. Nhóm liên ngành EBP

Sự tham gia của đại diện các chuyên ngành phù hợp trong nhóm EBP là rất quan trọng đối với sự thành công của nhóm. Thành phần tham gia vào nhóm tùy thuộc vào phạm vi của vấn đề. Ví dụ, nếu vấn đề là quản lý hạ thân nhiệt sau phẫu thuật, thì nên bao gồm đại diện tham gia là về gây mê và phẫu thuật. Dự đoán phương thức thực hiện các khuyến nghị do nhóm đưa ra và đối tượng ảnh hưởng về thực hành cũng giúp xác định cá nhân hoặc nhóm nào nên tham gia — với tư cách là thành viên trong nhóm hoặc với tư cách là các bên liên quan.

Nhóm EBP phải bao gồm các thành viên có chuyên môn về vấn đề thực hành đang được xem xét. Thông thường, điều này có nghĩa là một nhóm bao gồm điều dưỡng, bác sĩ và các nhân viên trong lĩnh vực khác, những người đóng góp đáng kể vào việc chăm sóc đối tượng người bệnh đã chọn.

Ví dụ: nếu câu hỏi liên quan đến các phương pháp tốt nhất trong việc kiểm soát chứng buồn nôn cho người bệnh đang hóa trị, nhóm có thể bao gồm điều dưỡng, dược sĩ và bác sĩ chuyên ngành ung thư. Số lượng thành viên phải đủ nhỏ để thúc đẩy hiệu quả và đủ lớn để cung cấp nội dung chuyên môn — thường là sáu đến tám người.

Các thành viên trong nhóm phải đồng ý tham dự các cuộc họp, xem xét và trình bày bằng chứng, tham gia vào việc tổng hợp bằng chứng, đưa ra các khuyến nghị thực hành, đóng góp và hỗ trợ các quyết định của nhóm. Các nhóm chưa từng làm EBP trước đây có thể tìm một người cố vấn có kinh nghiệm giúp họ khi lần đầu tiên thực hiện quá trình này. Sau khi nhóm được tập hợp và sẵn sàng bắt đầu quá trình EBP, các thành viên sẽ chọn một trưởng nhóm. Người lãnh đạo này phải là người có thể tạo điều kiện cho các cuộc họp, quản lý các dự án, nêu rõ các khuyến nghị của nhóm và ảnh hưởng đến việc thực hiện. Người lãnh đạo thiết lập lịch họp thường xuyên để các thành viên có thể sắp xếp thời gian, đây đôi khi là phần thách thức nhất trong việc lập kế hoạch dự án EBP.

Lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp với nhu cầu của khu vực lâm sàng với mốc thời gian phù hợp thực tế để hoàn thành dự án là điều cần thiết. Các thành viên trong nhóm làm

việc nhiều ca, nhiều ngày và ở các vai trò khác nhau hiếm khi có thể thống nhất về ngày giờ mà không cần thông báo trước hai tháng. Đôi khi, các nhóm có lịch họp thường xuyên để cải tiến chất lượng, xem xét thủ tục, chính sách hoặc trách nhiệm chuyên môn khác sử dụng thời gian họp tiêu chuẩn này cho dự án EBP.

Một số nhóm lên lịch họp sơ bộ để tinh chỉnh câu hỏi thực hành, sau đó là một hoặc hai ngày hành chánh để xem xét bằng chứng và đưa ra khuyến nghị. Các nhóm khác đã giải quyết khó khăn về việc lên lịch bằng cách dành ra các khoảng thời gian bốn giờ hàng tháng hoặc năm hay hai giờ họp cho các mỗi tuần khác. Lên lịch họp hàng tuần nếu có thể hoặc hai tuần một lần giúp nhóm tiếp tục tiến độ. Sự chậm trễ giữa các cuộc họp nhóm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến động lực của nhóm.

b. Vấn đề thực hành

Các thành viên trong nhóm liên ngành bắt đầu nhiệm vụ của họ bằng cách xác định vấn đề thực hành — một hoạt động quan trọng bởi vì tất cả các hành động và quyết định tiếp theo đều dựa trên việc xác định vấn đề rõ ràng. Quá trình này thường bắt đầu bằng cách tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề thực tế, chẳng hạn như:

- Có bằng chứng cho thấy phương pháp điều trị này có hiệu quả không?
- Thực hành này có giúp ích cho người bệnh không?
- Tại sao chúng ta lại thực hành như thế, và chúng ta có nên làm theo cách này không?
- Có cách nào để thực hành hiệu quả hơn hoặc tiết kiệm chi phí hơn không?

Vấn đề thực hành có thể xuất hiện từ nhiều nguồn. Trong 2 ấn phẩm kinh điển của Titler và cộng sự năm 1994 và năm 2001, đã xác định các yếu tố kích hoạt tập trung vào vấn đề hoặc tập trung vào kiến thức là nguồn gốc của vấn đề. Các yếu tố kích hoạt tập trung vào vấn đề là những yếu tố được xác định qua giám sát hàng ngày các dữ liệu về chất lượng, rủi ro, sự kiện bất lợi, tài chính hoặc các tiêu chuẩn. Các yếu tố kích hoạt tập trung vào kiến thức được xác định thông qua việc đọc các báo cáo đã công bố hoặc tìm hiểu thông tin mới tại các hội nghị hoặc cuộc họp chuyên môn.

Bảng 3.1. Nguồn gốc của vấn đề thực hành hành dựa trên bằng chứng

Loại kích hoạt	Nguồn bằng chứng
Tập trung vào vấn đề	- Mối quan tâm về tài chính - Câu hỏi về bằng chứng cho thực hành hiện tại - Mối quan tâm về chất lượng (năng suất, hiệu quả, kịp thời, công bằng, lấy người bệnh làm trung tâm) - Mối quan tâm về quản lý rủi ro hoặc an toàn - Kết quả người bệnh, nhân viên hoặc tổ chức không đạt yêu cầu

	- Sự khác biệt về thực hành so với các tổ chức bên ngoài - Sự khác biệt về thực hành trong cùng bối cảnh
Tập trung vào kiến thức	- Các nguồn bằng chứng mới - Những thay đổi trong tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn thực hành - Những triết lý mới về chăm sóc - Thông tin mới từ các ủy ban, tổ chức.

Các vấn đề cũng có thể là vấn đề lặp lại hoặc các vấn đề đầu tiên trong một tổ chức, hoặc một hoạt động thực hành có lợi ích còn nghi ngờ. Các câu hỏi lâm sàng có thể tìm hiểu các kết quả khác nhau trong cùng một nhóm người bệnh. Ví dụ, tại sao một số người bệnh tại khoa chăm sóc tích cực (ICU) tăng tỉ lệ viêm phổi do thở máy, trong khi những người bệnh ICU khác thì không? Có thể có sự khác biệt trong thực hành giữa các điều dưỡng, đơn vị chăm sóc hoặc các đồng nghiệp bên ngoài đơn vị.

Khả năng đặt ra các câu hỏi thực hành từ các vấ đề là vô hạn, và các dự án EBP có khả năng cải thiện về sức khỏe, tổ chức hệ thống hoặc giáo dục. Các vấn đề quan trọng là những vấn đề có thể gây hại, mang đến kết quả không tốt hoặc hao tốn nguồn lực. Các vấn đề quan trọng đáng được xem xét trước khi bắt đầu dự án EBP để dành thời gian và công sức cho những câu hỏi có khả năng mang lại lợi ích.

Công cụ phát triển câu hỏi dựa trên mô hình thực hành dựa trên bằng chứng của John Hopkins có thể được sử dụng để tạo một câu hỏi thực hành bắt đầu bằng việc nêu vấn đề rõ ràng - cơ sở của bất kỳ câu hỏi EBP nào có thể trả lời được. Thời gian để xác định vấn đề một cách rõ ràng và ngắn gọn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một câu hỏi EBP tốt. Mục đích là chuyển đổi nhu cầu kiến thức thành một câu hỏi có thể trả lời được.

Bảng 3.2. Chiến lược xác định vấn đề thực hành dựa trên bằng chứng

Chiến lược	Cơ sở lý luận
Cụm từ nêu vấn đề về lỗ hổng kiến thức không phải là giải pháp: "*Các phương pháp tốt nhất để kiểm soát đau cho người bệnh thay khớp gối toàn phần ngay sau khi thay xuất viện chưa được biết đến"*, thay vì "*Người bệnh cần một phương pháp quản lý đau tốt hơn ngay sau khi xuất viện*".	Cho phép nhóm thấy các giải pháp khác, có khả năng hiệu quả hơn.
Nêu vấn đề hơn là các dấu hiệu của vấn đề "40% người bệnh xuất viện sau thay khớp gối toàn phần than phiền rằng họ không thể kiểm soát cơn	Cho phép nhóm đi đến vấn đề thực sự, quy mô và phạm vi của nó, mà không bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài.

đau", thay vì "Người bệnh thay khớp gối toàn phần không hài lòng sau khi xuất viện".	
Mô tả bằng các thuật ngữ chính xác khoảng cách nhận thức giữa cái người ta nhìn thấy và cái người ta muốn xem: "*Sự hài lòng của người bệnh đối với việc kiểm soát cơn đau sau khi xuất viện là 36% so với tiêu chuẩn quốc gia là 85%."*	Cho phép nhóm đánh giá tình trạng hiện tại và hình dung trong tương lai, khi đã sửa chữa các vấn đề, phòng ngừa các rủi ro, chấp nhận các bằng chứng và cung cấp những thiếu hụt.
Xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và đảm bảo rằng cuối cùng sẽ xác định vấn đề thực sự: "*Người bệnh có hiểu chế độ quản lý đau của họ không?" chứ không phải là, "Người bệnh có đang tuân theo chế độ quản lý đau đã được chỉ định không"*	Cho nhóm thời gian để thu thập thông tin, quan sát, lắng nghe và thăm dò để đảm bảo hiểu đúng về vấn đề
Đặt câu hỏi rõ ràng: *"Khi nào những người bệnh này trải qua cơn đau? Các yếu tố thúc đẩy cơn đau là gì? Họ dùng thuốc giảm đau như thế nào? "*	Những câu hỏi như "tại sao" giúp nhóm đi đến vấn đề thực sự.
Không đổ lỗi cho các tác nhân bên ngoài hoặc tập trung sự chú ý vào khía cạnh sai của vấn đề. *Đừng đổ lỗi, chẳng hạn như "Người bệnh không tuân thủ điều trị bằng thuốc giảm đau theo chỉ định" hoặc "Điều dưỡng đã không giáo dục người bệnh đúng cách về tầm quan trọng của việc dùng thuốc giảm đau theo chỉ định".*	Giữ cho nhóm tập trung vào các quy trình và hệ thống khi nhóm chuyển sang xác định câu hỏi EBP.
Nêu vấn đề theo một cách khác: *"40% người bệnh thay khớp gối toàn phần có điểm số hài lòng thấp liên quan đến quản lý cơn đau sau khi xuất viện."*	Sử dụng các động từ khác nhau có thể giúp hiểu rõ hơn.
Nghi ngờ các giả định Nhóm giả định rằng người bệnh đã mua đơn thuốc giảm đau và đang uống thuốc giảm đau theo toa. *"Đây có phải là một giả định đúng?"*	Giúp nhóm tránh phỏng đoán và đặt câu hỏi về những điều được coi là đương nhiên hàng ngày.

Mở rộng và liên kế vấn đề: *"Có phải sự không hài lòng với việc kiểm soát đau sau khi xuất viện là một phần của sự không hài lòng về quá trình nằm viện nói chung không?" hoặc "Liệu có nhiều lý do dẫn đến việc không hài lòng với việc kiểm soát đau sau khi xuất viện không, chẳng hạn như không có khả năng chi trả cho thuốc giảm đau hoặc sợ trở nên phụ thuộc vào thuốc giảm đau?"*	Giúp nhóm hiểu xem vấn đề là một phần của vấn đề lớn hơn hay được tạo thành từ nhiều vấn đề nhỏ hơn.
Đưa ra nhiều giải pháp: *"Các phương pháp tốt nhất để kiểm soát đau sau khi xuất viện ở người bệnh thay khớp gối toàn phần là gì?" thay vì "Thực hành tốt nhất để kiểm soát đau sau khi xuất viện ở người bệnh thay khớp gối toàn phần là gì?"*	Giúp nhóm xác định nhiều giải pháp khả thi để xác định giải pháp phù hợp nhất cho đối tượng quan tâm.

Sau khi xác định vấn đề, nhóm mô tả cách làm hiện tại. Việc này giúp làm rõ các quy trình cụ thể có thể là nguồn gốc của vấn đề và thiết lập dữ liệu nền. Sau đó, nhóm xác định trọng tâm của vấn đề (lâm sàng, giáo dục hoặc hành chính) và lưu ý cách vấn đề được xác định. Sẽ rất hữu ích nếu ghi lại những thông tin này trên bộ Công cụ Phát triển Câu hỏi.

Xác định phạm vi của vấn đề (cá nhân, dân số, hoặc hệ thống/tổ chức) là nhiệm vụ tiếp theo cho nhóm. Ai là người bị ảnh hưởng bởi vấn đề? Nó xảy ra ở đâu? Vấn đề nổi lên khi nào? Việc xác định phạm vi của vấn đề ảnh hưởng đến việc lựa chọn các bên liên quan, những người liên quan hoặc cần được cung cấp thông tin.

Các dự án thực hành dựa trên bằng chứng đòi hỏi thời gian, bằng chứng sẵn có, kỹ năng EBP, chuyên gia cố vấn và hỗ trợ lãnh đạo. Do đó, mô hình và quy trình EBP có thể không thực tế cho tất cả các câu hỏi. Chọn những câu hỏi có tỷ suất lợi nhuận cao về quy trình chất lượng, kết quả và/hoặc hiệu quả về chi phí. Trước khi bắt tay vào dự án EBP và cam kết thời gian và nguồn lực cần thiết, hãy xem xét các câu hỏi sau: Liệu những thay đổi về thực hành từ dự án này có cải thiện kết quả lâm sàng, quy trình của đơn vị, sự hài lòng của người bệnh hoặc điều dưỡng không? Liệu chúng có giúp giảm chi phí chăm sóc? Các thay đổi thực hành có thể được thực hiện với văn hóa, thông lệ và cơ cấu tổ chức hiện tại trong môi trường thực hành cụ thể? Nếu vấn đề là quan trọng và một giải pháp có khả năng cải thiện chất lượng chăm sóc, thì việc đưa ra câu hỏi tập trung là bước tiếp theo của nhóm.

c. Các dạng câu hỏi thực hành

**** Độ nhạy và độ đặc hiệu***

Có hai loại câu hỏi EBP – Độ nhạy và độ đặc hiệu (Sackett, Rosenberg, Grey, Haynes, & Richardson, 1996; Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg, & Haynes, 2000).

Câu hỏi có độ nhạy cao là một câu hỏi chung, câu hỏi thực hành tốt nhất, rộng và tạo ra nhiều bằng chứng để xem xét: "Những can thiệp điều dưỡng tốt nhất để kiểm soát cơn đau cho những người bệnh có tiền sử lạm dụng chất gây nghiện là gì?" Câu hỏi này sẽ đưa ra bằng chứng liên quan đến dược lý học, các liệu pháp thay thế, kết hợp hành vi và các định kiến trong việc kê đơn và sử dụng thuốc giảm đau. Bằng chứng xác định cho các câu hỏi độ nhạy cao thường cung cấp "tình trạng khoa học" về một vấn đề và có thể dẫn đến một câu hỏi độ đặc hiệu tốt.

Câu hỏi có độ đặc hiệu cao là một câu hỏi tập trung bao gồm các so sánh cụ thể: "Liệu kết hợp hành vi hoặc thiết lập mục tiêu chung có hiệu quả hơn trong việc cải thiện trải nghiệm đau cho người bệnh có tiền sử lạm dụng chất kích thích không?" Các câu hỏi độ đặc hiệu cao tạo ra bằng chứng tốt, giới hạn cụ thể cho câu hỏi EBP. Khi một nhóm EBP đặt câu hỏi có độ nhạy cao, việc xem xét bằng chứng có thể trở nên phức tạp. Sẽ rất hữu ích nếu tổ chức dự án EBP bằng cách chia nhỏ các thành phần của vấn đề thành một số lượng câu hỏi đặc hiệu thích hợp. Tạo câu hỏi liên quan đến từng thành phần đã xác định.

Ví dụ, nếu vấn đề là tỷ lệ té ngã cao ở người bệnh nội trú lớn tuổi, câu hỏi có độ nhạy có thể là, "Thực hành tốt nhất để phòng ngừa té ngã cho người bệnh lớn tuổi là gì?" Một câu hỏi có độ đặc hiệu thích hợp có thể là, "Phương pháp thực hành nào hiệu quả hơn trong việc giảm chấn thương do ngã: báo thức tại giường hoặc xoay vòng theo giờ?"

d. Câu hỏi lâm sàng là gì?

Các câu hỏi lâm sàng tạo cơ sở cho việc tìm kiếm tài liệu để xác định bằng chứng hỗ trợ từ nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin cho việc phát triển hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn lâm sàng, quy trình và chính sách hướng dẫn tốt nhất cho thực hành nghề điều dưỡng và hợp tác liên ngành. Các câu hỏi lâm sàng có bốn thành phần cơ bản:

- Dân số và vấn đề
- Sự can thiệp
- So sánh
- Kết quả

Các thành phần này, được gọi là PICO, cung cấp một định dạng hiệu quả để phát triển tập trung và có thể tìm kiếm câu hỏi lâm sàng. PICO là một công cụ giúp hình thành câu hỏi lâm sàng. Ý nghĩa của câu hỏi lâm sàng trở nên rõ ràng khi bằng chứng nghiên cứu từ cuộc tìm kiếm được thẩm định một cách nghiêm túc. Bằng chứng nghiên cứu, đánh giá lâm sàng

và mong muốn của người bệnh được sử dụng để đánh giá, phát triển hoặc xem lại các phương pháp tốt nhất. Việc xác định P- dân số, vấn đề hoặc bối cảnh người bệnh P - có vẻ như là điều hiển nhiên với nhà lâm sàng hoặc với một nhóm. Tuy nhiên, nó thường được nêu quá chung chung và có thể gây sai lầm khi sử dụng các cụm từ tìm kiếm trong thiết kế tìm kiếm bằng chứng.

Bảng 3.3. Phân loại câu hỏi lâm sàng và loại nghiên cứu cung cấp bằng chứng tốt nhất

Câu hỏi lâm sàng	Loại câu hỏi	Loại nghiên cứu cung cấp bằng chứng tốt nhất
Làm thế nào vấn đề có thể được phòng ngừa?	Phòng ngừa	Thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng Tổng quan hệ thống
Liệu việc phát hiện vấn đề sớm, trước khi có triệu chứng, có tạo ra sự khác biệt trong sức khỏe của tôi không?	Tầm soát	Thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng Tổng quan hệ thống Đoàn hệ
Kiểm tra này tốt như thế nào để phát hiện vấn đề của tôi?	Chẩn đoán	Đoàn hệ
Kết quả có thể xảy ra của vấn đề này là gì?	Tiên lượng	Đoàn hệ
Tỷ lệ dân số mới được chẩn đoán với vấn đề này mỗi năm là bao nhiêu?	Tỷ lệ mắc	Đoàn hệ
Tỷ lệ dân số hiện đang sống với vấn đề này là bao nhiêu?	Tỷ lệ lưu hành	Bệnh chứng/ Đoàn hệ
Nguyên nhân nào gây ra vấn đề?	Căn nguyên	Thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng Tổng quan hệ thống
Cần phải làm gì để điều trị vấn đề này?	Liệu pháp	Thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng Bệnh chứng
Sẽ có bất kỳ tác động tiêu cực nào từ một can thiệp?	Tác hại	

e. Vì sao các câu hỏi lâm sàng lại quan trọng?

Các nhà lâm sàng bận rộn, có thể bị choáng ngợp bởi khối lượng tài liệu phải truy cập, hãy ngồi xuống xem qua và đánh giá để xác định phương pháp thực hành tốt nhất được hỗ trợ bởi bằng chứng mạnh mẽ nhất có thể áp dụng cho vấn đề của người bệnh và thực hành. Hơn

nữa, không có hai người bệnh nào hoàn toàn giống nhau, và các đồng nghiệp có thể có ý kiến khác nhau về phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề của người bệnh.

Khi các thành viên trong nhóm suy nghĩ về câu hỏi lâm sàng muốn phát triển, có thể hữu ích khi nghĩ về mục đích hoặc mục tiêu của dự án dựa trên bằng chứng mong muốn thực hiện. Mục đích của một dự án dựa trên bằng chứng bao gồm những gì mà nhóm lâm sàng nhắm tới đầu tiên. Khi mục đích được công bố, nó gợi ý phương pháp dùng để để định hướng dự án. Khi mục đích của dự án dựa trên bằng chứng là đưa ra câu hỏi lâm sàng so sánh hiệu quả của hai biện pháp can thiệp, việc tìm kiếm bằng chứng sẽ được liên kết với các nghiên cứu can thiệp hoặc liệu pháp tập trung vào việc kiểm tra hiệu quả của các can thiệp được truy vấn trong câu hỏi PICO.

Ví dụ: nếu mục đích của một dự án dựa trên bằng chứng nhằm trả lời rằng liệu trong nhóm người bệnh trước phẫu thuật, việc sử dụng âm nhạc so với không sử dụng âm nhạc sẽ có tác dụng đáng kể trong việc giảm lo lắng trước phẫu thuật hay không, thì việc tìm kiếm bằng chứng tốt nhất hiện có sẽ tập trung vào các nghiên cứu tổng quan hệ thống Cấp I, các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cấp II (RCT) hoặc các thiết kế bán thực nghiệm Cấp III.

Các câu hỏi lâm sàng rất quan trọng vì chúng cung cấp một định dạng có cấu trúc tập trung vào việc tìm kiếm câu trả lời cho một yếu tố kích hoạt tập trung vào vấn đề hoặc kiến thức cụ thể. Việc hình thành câu hỏi PICO tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm tài liệu để xác định và truy xuất thông tin phù hợp và kịp thời để có thể chia sẻ thông tin tốt nhất sẵn có với đồng nghiệp và người bệnh. Tích hợp phương pháp tiếp cận tìm kiếm bằng chứng chủ động vào cách thực hành lâm sàng là điều cần thiết để duy trì sự vượt trội về thực hành lâm sàng nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, hiệu quả về chi phí và làm hài lòng người bệnh và nhân viên y tế (IHI, 2012).

g. Các loại câu hỏi PICO

Một câu hỏi PICO được phát triển tốt có những ưu điểm sau:

- Giúp làm rõ vấn đề lâm sàng và thông tin cần thiết để giải quyết nó.
- Giúp xác định loại bằng chứng cần thiết tương ứng với loại nghiên cứu.
- Giúp cung cấp các thuật ngữ làm cho việc tìm kiếm bằng chứng hiệu quả hơn.

Phân loại câu hỏi PICO theo loại câu hỏi là một cách tiếp cận, có các dạng câu hỏi lâm sàng khác nhau tùy thuộc vào loại câu hỏi lâm sàng. Ví dụ, câu hỏi lâm sàng, "Hiệu quả của CBT so với liệu pháp chống trầm cảm trong việc giảm trầm cảm ở những người được chẩn đoán ung thư là gì?" gợi ý suy nghĩ về liệu pháp nào hiệu quả nhất để điều trị người bệnh này hoặc nhóm người bệnh. Nói chung, loại nghiên cứu có khả năng cung cấp bằng chứng tốt nhất để trả lời loại câu hỏi lâm sàng trị liệu này là thử nghiệm ngẫu nhiên.

** Câu hỏi lâm sàng khác với câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết*

Câu hỏi lâm sàng khác với các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết trong cách tiếp cận của chúng. Chúng nghe có vẻ giống nhau, nhưng mục đích khác nhau. Cả câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết đều là những bước sơ bộ quan trọng trong việc thực hiện các nghiên cứu và hướng dẫn thiết kế và thực hiện một nghiên cứu. Cả hai đều được các nhà nghiên cứu sử dụng để kiểm tra các mối quan hệ giữa các biến. Câu hỏi nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi giải quyết lỗ hổng hoặc mâu thuẫn trong tài liệu. Họ kiểm tra mối quan hệ có thể đo lường được giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trong nghiên cứu. Phần còn lại của nghiên cứu sẽ thấp hơn câu hỏi nghiên cứu.

Câu hỏi nghiên cứu được trả lời bởi những kết quả của nghiên cứu. Một câu hỏi nghiên cứu được viết đúng cách sẽ rõ ràng và súc tích. Nó phải chứa chủ đề đang được nghiên cứu (mục đích), (các) biến số và đối tượng nghiên cứu. Các giả thuyết được sử dụng trong các nghiên cứu để dự đoán (các) kết quả của nghiên cứu. Một giả thuyết có bản chất là dự đoán và thường được sử dụng khi đã có kiến thức quan trọng về chủ thể cho phép thực hiện dự đoán. Cả câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết đều được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu định lượng. Được hướng dẫn bởi các câu hỏi lâm sàng, các nhà lâm sàng tìm kiếm và sử dụng bằng chứng từ các kết quả nghiên cứu để trả lời các câu hỏi lâm sàng.

Sau khi được tìm thấy và thu thập, bằng chứng sẽ được đánh giá nghiêm ngặt, và dựa trên sức mạnh, chất lượng và tính nhất quán của bằng chứng, nó được sử dụng để trả lời câu hỏi lâm sàng bằng cách xác định xem bằng chứng có thể áp dụng cho thực hành lâm sàng hay không và để cung cấp cơ sở cho thực hiện thực hành dựa trên bằng chứng.

***TÓM LẠI:**

Nhân viên y tế ngày càng quan tâm đến việc đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc mà họ cung cấp là dựa trên bằng chứng. Với vai trò lãnh đạo, bạn được yêu cầu cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng và hiệu quả về chi phí cho chương trình hoặc nhóm người bệnh. Các nghiên cứu cá nhân, tổng quan hệ thống và hướng dẫn lâm sàng là các sản phẩm dựa trên bằng chứng sẽ sử dụng để hỗ trợ thực hành. Hình thành các câu hỏi lâm sàng là điều cơ bản và là bước đầu tiên trong quy trình thực hành dựa trên bằng chứng.

Các câu hỏi lâm sàng chuyển đổi các tình huống và vấn đề thành các câu hỏi có thể trả lời được được sử dụng để hướng dẫn tìm kiếm bằng chứng tốt nhất hiện có, cùng với kiến thức chuyên môn lâm sàng và mong muốn của người bệnh mà nhân viên y tế sẽ sử dụng để tạo ra sự khác biệt và đóng vai trò như một hình mẫu cho đồng nghiệp. Khi nhân viên y tế trở nên tự tin như một trưởng nhóm lâm sàng thực hành dựa trên bằng chứng, một khía cạnh khác trong vai trò của nhân viên y tế sẽ là cố vấn cho các điều dưỡng thực hành, điều dưỡng và

đồng nghiệp khác để phát triển câu hỏi lâm sàng của họ và các năng lực thực hành dựa trên bằng chứng khác.

CHƯƠNG IV.
PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH BẰNG CHỨNG

1. Tìm kiếm và phân tích tài liệu

a. Các định dạng thông tin chính

Điều dưỡng có nhiều nguồn dữ liệu nghiên cứu hỗ trợ cho việc chăm sóc dựa trên bằng chứng đang liên tục phát triển (Collins, Voth, DiCenso, & Guyatt, 2005). Tài liệu dựa trên bằng chứng đến từ nhiều nguồn, và điều dưỡng cần ghi nhớ tất cả chúng. Tìm kiếm tài liệu là một thành phần quan trọng của quá trình thực hành dựa trên bằng chứng. Nếu các điều dưỡng chỉ tìm kiếm một nguồn tài liệu, cơ sở dữ liệu hoặc tạp chí, họ rất có thể sẽ bỏ sót các bằng chứng quan trọng. Thông qua việc tìm kiếm, điều dưỡng làm giàu thêm thực hành lâm sàng và kinh nghiệm trong việc xác định bằng chứng quan trọng đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc. Lý tưởng là, điều dưỡng tìm kiếm bằng chứng để trả lời các câu hỏi về chăm sóc người bệnh hoặc lâm sàng trước tiên có thể xem xét hồ sơ người bệnh được vi tính hóa để tổng hợp thông tin người bệnh và cung cấp lời nhắc tìm kiếm từ hồ sơ đó (Straus, Richardson, Glasziou, & Haynes, 2011). Tuy nhiên, thiếu một hệ thống như vậy, điều dưỡng phải tìm đến các nguồn khác để tìm bằng chứng hỗ trợ cho việc thực hành. Bằng chứng được chia thành ba loại chính: tài liệu dịch, tóm tắt bằng chứng và bằng chứng chủ yếu.

Tài liệu dịch đề cập đến các kết quả nghiên cứu dựa trên bằng chứng, sau nhiều nghiên cứu và phân tích, đã được chuyển thành các hướng dẫn được sử dụng trong bối cảnh lâm sàng. Nó bao gồm hướng dẫn thực hành, quy trình, tiêu chuẩn, phác đồ, đổi mới lâm sàng, trung tâm chăm sóc dựa trên bằng chứng, phản biện tạp chí và dữ liệu ấn phẩm. Một số nguồn tài liệu dịch từ Ngân hàng Hướng dẫn Quốc gia – Mỹ (National Guideline Clearinghouse), Hướng dẫn thực hành trọng yếu của trung tâm Joanna Briggs (the Best Practice Information Sheets of Joanna Briggs Institute), Chỉ số tích lũy tài liệu điều dưỡng và ngành sức khỏe (CINAHL), và PubMed. (Thông tin truy cập các nguồn này sẽ được đề cập trong chương này)

Tóm tắt bằng chứng bao gồm tổng quan hệ thống, tổng quan tích hợp, phân tích gộp, tổng quan tổng hợp và tổng hợp bằng chứng. Đây là những bản tóm tắt tài liệu xác định, lựa

chọn và đánh giá phê bình các nghiên cứu có liên quan và sử dụng phân tích thống kê hoặc diễn giải thích hợp để tóm tắt kết quả các nghiên cứu. Các bản tóm tắt dựa trên bằng chứng có thể được tìm thấy trong danh mục thư viện, các bộ sách trực tuyến và các tài nguyên trực tuyến, chẳng hạn như PubMed, CINAHL, Thư viện Cochrane, Viện Joanna Briggs và Cơ sở dữ liệu tóm tắt các đánh giá về hiệu quả (DARE). Đối với các nhà quản lý bệnh viện và người quản lý hồ sơ, Toàn văn Công tác Y tế là một nguồn để cải tiến chất lượng và thông tin tài chính.

Bằng chứng ban đầu là dữ liệu thường được thu thập từ việc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc đối tượng và bao gồm dữ liệu bệnh viện, thử nghiệm lâm sàng, tạp chí nghiên cứu có bình duyệt, báo cáo hội nghị và tóm tắt, sách chuyên khảo, cũng như tóm tắt từ các bộ dữ liệu như dữ liệu tối thiểu Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid. Cơ sở dữ liệu có thể từ PubMed, CINAHL, Cơ sở dữ liệu Excerpta Medica (EMBASE), danh mục thư viện và các kho lưu trữ của tổ chức. Đối với các nhà quản lý bệnh viện, Dự án Sử dụng và Chi phí Y tế (HCUP) là một nguồn để thống kê y tế và thông tin về việc sử dụng cho người bệnh nội trú và cấp cứu.

b. Câu hỏi có thể trả lời

Sau khi một vấn đề thực hành đã được xác định và chuyển đổi thành một câu hỏi EBP có thể trả lời được, việc tìm kiếm bằng chứng bắt đầu với các bước sau:

1. Xác định các từ khóa có thể tìm kiếm có trong câu hỏi thực hành dựa trên bằng chứng và liệt kê chúng trên bộ công cụ phát triển câu hỏi. Cũng bao gồm các thuật ngữ đồng nghĩa hoặc liên quan.

2. Xác định các loại thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi một cách tốt nhất và liệt kê các nguồn mà thông tin đó có thể được tìm thấy. (Các) cơ sở dữ liệu nào sẽ cung cấp thông tin tốt nhất để trả lời câu hỏi?

3. Phát triển chiến lược tìm kiếm

4. Đánh giá kết quả tìm kiếm về tính giá trị, uy tín và hữu ích.

5. Xem lại chiến lược tìm kiếm nếu cần.

6. Ghi lại các chi tiết cụ thể của chiến lược (thuật ngữ được sử dụng, giới hạn đã đặt ra, số năm tìm kiếm) trên Công cụ phát triển câu hỏi và lưu trữ kết quả.

*** Ví dụ về tìm kiếm thực hành dựa trên bằng chứng**

Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm bằng chứng là chọn các từ khóa có thể tìm kiếm được từ câu hỏi thực hành dựa trên bằng chứng có thể trả lời được. Bộ công cụ phát triển câu hỏi tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này bằng cách định hướng nhóm xác định vấn đề thực hành và sử dụng các thành phần PICO để phát triển câu hỏi tìm kiếm.

Ví dụ, hãy xem xét câu hỏi sau: "Những yếu tố nguy cơ nào liên quan đến chấn thương nghiêm trọng do té ngã trong cơ sở chăm sóc cấp tính dành cho người lớn?" Một số cụm từ tìm kiếm để sử dụng có thể là té ngã, các yếu tố rủi ro, người lớn và các cơ sở chăm sóc cấp tính.

Bảng 4.1. Ví dụ câu hỏi PICO: Yếu tố nguy cơ liên quan chấn thương do té ngã

P (Đối tượng, bối cảnh)	Người lớn tại đơn vị chăm sóc cấp tính
I (Can thiệp)	Xác định nguy cơ liên quan đến chấn thượng
C (So sánh)	Không áp dụng
O (Kết quả)	Giảm tỷ lệ chấn thương nghiêm trọng do té ngã

Các nhóm cần xem xét toàn bộ bối cảnh xung quanh vấn đề khi nghĩ đến các cụm từ tìm kiếm. Ví dụ, can thiệp là một thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong điều dưỡng; nó bao gồm đầy đủ các hoạt động mà điều dưỡng thực hiện trong việc chăm sóc người bệnh.

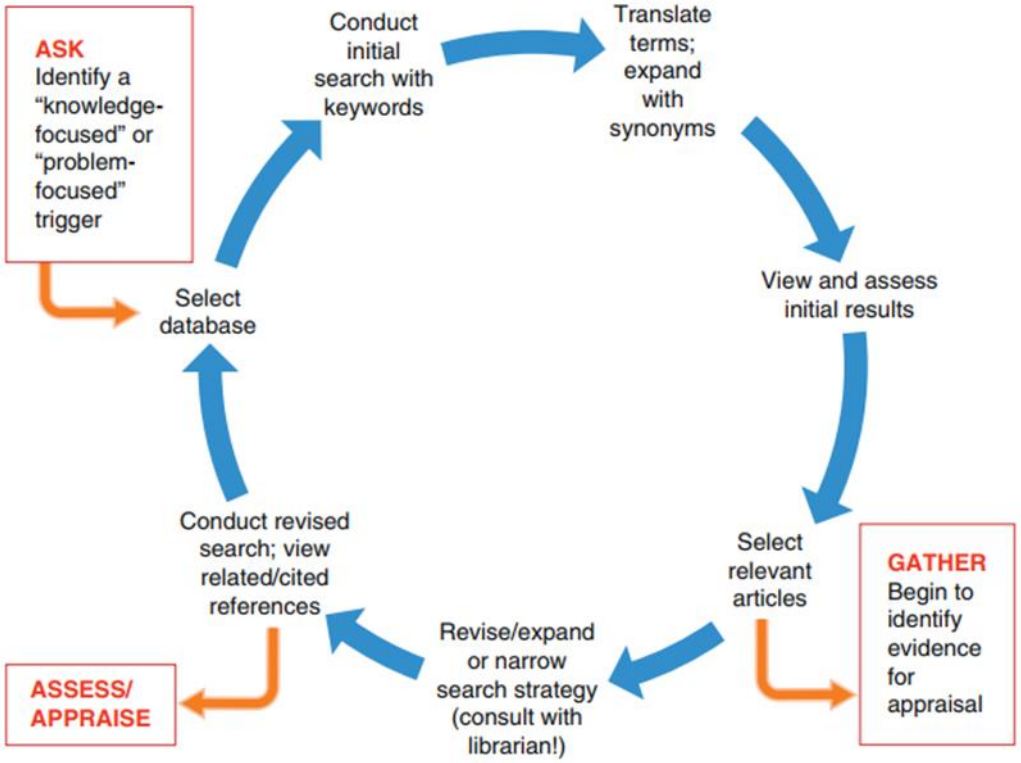
Tuy nhiên, việc tìm kiếm tài liệu về các can thiệp điều dưỡng là quá chung chung và cần tập trung vào các can thiệp cụ thể. Trong ví dụ trước "Các yếu tố nguy cơ liên quan đến chấn thương do té ngã", các can thiệp có thể bao gồm thuốc men, thiết bị và tấm trải sàn. Bảng 4.2 cho thấy sự phát triển của một câu hỏi trả lời được cho một vấn đề thực hành dựa trên bằng chứng cụ thể và chiến lược tìm kiếm tương ứng.

Bảng 4.2. Chiến lược tìm kiếm sự phân tâm và gián đoạn trong quá trình dùng thuốc

***Vấn đề** Ủy ban cải tiến chất lượng của bệnh viện đã chứng kiến sự gia tăng sai sót khi dùng thuốc và điều dưỡng chỉ ra rằng sự phân tâm và gián đoạn là yếu tố góp phần lớn nhất. Nhân viên của đơn vị không biết chiến lược nào tốt nhất để kiểm soát sự phân tâm và gián đoạn trong môi trường làm việc của họ trong quá trình thực hiện thuốc.	
PICO	
P (bệnh nhân, bối cảnh)	Điều dưỡng đơn vị chăm sóc bệnh nội trú
I (can thiệp)	Xác định và kiểm soát sự phân tâm và gián đoạn trong suốt quá trình thực hiện thuốc
C (So sánh)	Thực hành hiện tại
O (Kết quả)	Giảm tỷ lệ phân tâm và gián đoạn
Câu hỏi trả lời được: "Thực hành tốt nhất để giúp điều dưỡng tại các đơn vị điều trị nội trú nhận biết và kiểm soát sự phân tâm và gián đoạn trong quá trình thực hiện thuốc là gì?	

Nội dung được thiết kế và xây dựng bởi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Cụm từ tìm kiếm ban đầu	Cụm từ tìm kiếm liên quan
Nhân viên bệnh viện	Điều dưỡng, nhà lâm sàng
Sự phân tâm	Nhân viên y tế
Sai sót khi dùng thuốc	Tập trung, Sự gián đoạn
Thực hiện thuốc	



Sơ đồ 1. Quy trình tuần hoàn của việc hỏi, thu thập, đánh giá / thẩm định bằng chứng

Nguồn: Bernadette Mazurek Melnyk (2019)

b. Lựa chọn nguồn thông tin và bằng chứng

Sau khi lựa chọn các cụm từ tìm kiếm, nhóm thực hành dựa trên bằng chứng có thể xác định cơ sở dữ liệu chất lượng có chứa thông tin về chủ đề. Phần này đánh giá ngắn gọn một số tính năng độc đáo của cơ sở dữ liệu EBP cốt lõi về điều dưỡng và y học.

CINAHL

Chỉ số Tích lũy tài liệu về Điều dưỡng và ngành y tế (CINAHL) bao gồm điều dưỡng, y sinh, y học thay thế hoặc bổ sung, và 17 ngành sức khỏe khác. CINAHL có hơn 3.000 tạp chí, chứa hơn 2,3 triệu bản ghi có từ năm 1981, và bao gồm toàn bộ các tạp chí và ấn phẩm về điều dưỡng bằng tiếng Anh từ Liên đoàn Điều dưỡng Quốc gia và Hội Điều dưỡng Mỹ (ANA). Ngoài ra, CINAHL còn có các sách về chăm sóc sức khỏe, luận văn điều dưỡng, kỷ yếu hội nghị được chọn lọc, tiêu chuẩn hành nghề và các chương sách. Tài liệu toàn văn trong

CINAHL bao gồm hơn 70 tạp chí ngoài các trường được công nhận về mặt pháp lý, cải tiến lâm sàng, phác đồ, hồ sơ thuốc, công cụ nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng.

CINAHL cũng chứa một từ vựng được kiểm soát gọi là tiêu đề CINAHL (CINAHL Subject Headings) cho phép truy xuất chính xác hơn. Các thuật ngữ được tìm kiếm bằng cách dùng MH cho Tiêu đề - Chủ đề Chính xác hoặc MM cho Tiêu đề - Chủ đề gần Chính xác.

CINAHL cũng cho phép tìm kiếm bằng cách sử dụng các giới hạn chi tiết để thu hẹp kết quả theo loại xuất bản, độ tuổi, giới tính và ngôn ngữ. PICO về sự phân tâm có thể được tìm kiếm bằng cách sử dụng các tiêu đề CINAHL (MH "Mất tập trung") VÀ (MH "Lỗi do thuốc") kết hợp với các từ khóa làm mất tập trung và lỗi dùng thuốc. Chiến lược tìm kiếm sẽ giống như sau: ((MH "Mất tập trung") HOẶC phân tâm) VÀ ((MH "Sai sót do Dùng thuốc") HOẶC "sai sót do dùng thuốc").

MEDLINE và PubMed

MEDLINE và PubMed thường được sử dụng thay thế cho nhau; tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng không giống nhau. PubMed tìm kiếm MEDLINE, nhưng cũng tìm kiếm các bài báo chưa có trong MEDLINE và có trong PubMed Central.

MEDLINE, được cung cấp miễn phí thông qua giao diện của Thư viện Y khoa Quốc gia, PubMed, chứa hơn 18 triệu tài liệu tham khảo đến các bài báo trong khoa học đời sống tập trung vào nghiên cứu y sinh. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của MEDLINE là kho từ vựng phong phú, được kiểm soát: Tiêu đề Y khoa (MeSH). Mỗi bản ghi trong MEDLINE được xem xét bởi một người lập chỉ mục là một chuyên gia trong lĩnh vực y sinh. Người lập chỉ mục chia tiêu đề MeSH thích hợp cho mỗi bản ghi, điều này cho phép tìm kiếm chính xác bằng cách loại bỏ các bài báo không liên quan khi một từ khóa có thể tình cờ đề cập. Có một câu nói trong thế giới thư viện: "Nhập vào rác thì xuất ra rác" ("Garbage in, Garbage out") MeSH có thể loại bỏ các bài báo "rác" hoặc bài báo không liên quan.

Để tìm kiếm trong PubMed bằng cách sử dụng ví dụ PICO về sự phân tâm trong thực hiện thuốc, người ta sẽ sử dụng MeSH cho "Sai sót do dùng thuốc" ("Medication Errors"). MeSH không có thuật ngữ cho "sự phân tâm" ("distractions"), nhưng "sự phân tâm" có thể sử dụng như một từ khóa. Thuật ngữ MeSH liên quan của "Chú ý" ("Attention") [MeSH] cũng có thể được xem xét. Chiến lược tìm kiếm như sau: *("Medication Errors"[MeSH] OR "medication errors"[All Fields]) AND ("Attention"[MeSH] OR distraction [All Fields])*.

PubMed cũng chứa công cụ truy vấn lâm sàng, có các bộ lọc dựa trên bằng chứng được xây dựng trước. Truy vấn lâm sàng sử dụng các bộ lọc này để tìm thông tin liên quan về các chủ đề liên quan đến một trong năm danh mục nghiên cứu lâm sàng: liệu pháp, chẩn đoán, căn nguyên, tiên lượng và hướng dẫn dự đoán lâm sàng. Truy vấn lâm sàng cũng bao gồm một bộ

lọc tìm kiếm cho các tổng quan hệ thống. Bộ lọc này kết hợp các cụm từ tìm kiếm với một bộ lọc giới hạn kết quả cho các tổng quan hệ thống, phân tích gộp, tổng quan các thử nghiệm lâm sàng, y học chứng cứ, hội nghị phát triển đồng thuận và các hướng dẫn.

Thư viện Cochrane

Thư viện Cochrane là một tập hợp các cơ sở dữ liệu đáng chú ý nhất là Cơ sở dữ liệu Cochrane về các bài tổng quan hệ thống. Được quốc tế công nhận là tiêu chuẩn vàng trong chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng, Cochrane Reviews nghiên cứu tác động của các biện pháp can thiệp để phòng ngừa, điều trị và phục hồi chức năng. Họ cũng đánh giá độ chính xác của xét nghiệm chẩn đoán cho một tình trạng nhất định trong một nhóm người bệnh và bối cảnh cụ thể. Hiện có hơn 4.500 Tổng quan Cochrane và 2.000 hướng dẫn. Tóm tắt các tổng quan được cung cấp miễn phí trên trang web Cochrane; bài tổng quan đầy đủ yêu cầu phải đăng ký. Một nhân viên thư viện của cở y tế có thể xác định quyền truy cập của tổ chức vào thư viện này.

2. Đánh giá bằng chứng

a. Tổng quan hệ thống

Tổng quan hệ thống tóm tắt bằng chứng nghiên cứu đã được thẩm định nghiêm túc (thường là các nghiên cứu thực nghiệm và bán thực nghiệm) liên quan đến một câu hỏi cụ thể. Các tổng quan này sử dụng và ghi lại các chiến lược tìm kiếm toàn diện và các phương pháp thẩm định minh bạch, chặt chẽ. Giảm thiểu thiên lệch khi một nhóm chuyên gia, chứ không phải cá nhân, áp dụng các phương pháp chuẩn hóa cho quá trình tổng quan. Tổng quan hệ thống thường sử dụng phân tích gộp hoặc tổng quan tổng hợp để tóm tắt kết quả của các nghiên cứu độc lập. Khi các tổng quan hệ thống tóm tắt kết quả của các nghiên cứu định lượng độc lập, chúng được gọi là phân tích gộp.

Phân tích gộp cung cấp một ước tính chính xác hơn về tác động của các biện pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe so với các kết quả thu được từ các nghiên cứu riêng lẻ được đưa vào tổng quan (Higgins và Green, 2011). Thông qua việc sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích gộp giúp hiểu được tính nhất quán của bằng chứng giữa các nghiên cứu.

Khi một tổng quan hệ thống tóm tắt kết quả của các nghiên cứu định tính độc lập, chúng được gọi là tổng quan tổng hợp. Trong một bài tổng quan hệ thống với tổng quan tổng hợp, người ta cố gắng kết hợp các kết quả từ một số nghiên cứu định tính để đi đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về hiện tượng đang được xem xét. Tổng quan tổng hợp tạo ra một cách diễn giải rộng hơn những gì có thể đạt được từ một nghiên cứu định tính đơn lẻ.

b. Phân tích gộp

Phân tích gộp là một loại bằng chứng khoa học tổng hợp và phân tích định lượng các kết quả của nhiều nghiên cứu trước đó đã giải quyết một câu hỏi nghiên cứu tương tự nhau (Polit & Beck, 2008). Phân tích gộp sử dụng "các kỹ thuật thống kê trong tổng quan hệ thống để tích hợp kết quả của các nghiên cứu được đưa vào" (Moher, Liberati, Tetziaff, Altman, & the PRISMA Group, 2009, trang 1007). Một phân tích gộp có thể dựa trên dữ liệu người bệnh riêng lẻ từ các nghiên cứu trước đủ giống nhau để kết hợp với nhau, hoặc mỗi nghiên cứu có thể đóng vai trò như một đơn vị phân tích. Các phân tích gộp mạnh nhất chỉ bao gồm các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT). Các bài phân tích gộp chứa các nghiên cứu bán thực nghiệm xếp hạng thấp hơn các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng.

Một tham số chung được gọi là hệ số ảnh hưởng (effect size - ES), thước đo sức mạnh của mối quan hệ giữa hai biến số, được phát triển cho mỗi nghiên cứu ban đầu. Hệ số ảnh hưởng dương cho thấy mối quan hệ thuận (khi một biến tăng, biến thứ hai cũng tăng); hệ số ảnh hưởng âm cho biết mối quan hệ nghịch (khi một biến tăng hoặc giảm, biến thứ hai theo hướng ngược lại). Bằng cách kết hợp các kết quả trong một số nghiên cứu nhỏ hơn, nhà nghiên cứu có thể tăng khả năng hoặc xác suất phát hiện mối quan hệ thực sự giữa can thiệp và kết quả của can thiệp (Polit & Beck, 2008). Khi kết hợp các nghiên cứu để phân tích gộp, nhà nghiên cứu chỉ có thể phân tích thống kê các biến độc lập và kết quả (biến phụ thuộc) mà các nghiên cứu có điểm chung.

Một thống kê tóm tắt chung kết hợp và tính trung bình các hệ số ảnh hưởng qua các nghiên cứu. Điều tra viên nên mô tả phương pháp xác định hệ số ảnh hưởng và sẽ giúp người đọc giải thích số liệu thống kê.

Phương pháp luận của Cohen (1988) xác định hệ số ảnh hưởng bao gồm độ mạnh của tương quan xếp hạng như sau: không đáng kể (ES = 0,01–0,09), thấp đến trung bình (0,10–0,29), trung bình đến đáng kể (0,30–0,49), đáng kể đến rất mạnh (0,50–0,69), rất mạnh (0,70–0,89), và gần như hoàn hảo (0,90–0,99).

c. Meta – synthesis

Tổng quan tổng hợp (Meta – synthesis)

Ngược lại với nghiên cứu định lượng dựa trên con số, nghiên cứu định tính dựa trên văn bản. Các nhà nghiên cứu định tính thu thập các tài liệu tường thuật phong phú; tích hợp các dữ liệu này để đưa ra một bản tường thuật hoặc phiên dịch lớn hơn (Polit & Beck, 2008).

Tổng quan tổng hợp được coi như là một đối chứng định tính với phân tích gộp, nhưng liên quan đến việc diễn giải hơn là tổng hợp dữ liệu hoặc tạo ra một thống kê tóm tắt (Beck, 2009a). Cả hai đều sử dụng các kỹ thuật khoa học nghiêm ngặt.

Có một số phương pháp tổng quan tổng hợp khác nhau. Phương pháp thường được sử dụng nhất là tổng quan dân tộc học (meta-ethnography) so sánh các phép ẩn dụ (khái niệm, chủ đề và cụm từ) được đưa vào các nghiên cứu định tính riêng lẻ và tổng hợp các bản dịch này thành một cách diễn giải được thể hiện trực quan thông qua tác phẩm viết, kịch, nghệ thuật hoặc âm nhạc (Beck, 2009a). Bắt nguồn từ lĩnh vực giáo dục như một giải pháp thay thế cho phân tích gộp (Noblit & Hare, 1988, trang 5), tổng quan dân tộc học (metaethnography) trả lời câu hỏi "làm thế nào để 'tập hợp' các bản diễn giải bằng văn bản" và đưa vào nghiên cứu định tính bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận đa dạng (Barnett-Page & Thomas, 2009). Các phương pháp tổng quan tổng hợp khác bao gồm lý thuyết nền (grounded theory), tổng hợp theo chủ đề (thematic synthesis), tổng hợp văn bản tường thuật (textual narrative synthesis), nghiên cứu tổng hợp (meta-study), tổng hợp tường thuật (meta-narrative) và tam giác sinh thái (ecological triangulation) (Barnett-Page & Thomas, 2009). Đối với những điều dưỡng thiếu kinh nghiệm và chuyên môn trong việc phân tích các nghiên cứu định tính, tổng quan tổng hợp rất hữu ích vì chúng không chỉ hỗ trợ trong việc đánh giá mức độ nghiêm ngặt của các nghiên cứu riêng lẻ mà còn giúp giải thích các kết quả.

d. Nghiên cứu thực nghiệm

Các nghiên cứu thực nghiệm, hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT), sử dụng phương pháp khoa học truyền thống. Điều tra viên thu được kiến thức có thể xác minh, khách quan, dựa trên nghiên cứu bằng cách quan sát hoặc đo lường theo cách sao cho bằng chứng thu được có thể tái tạo được. Các loại thiết kế thử nghiệm mà nhóm thực hành dựa trên bằng chứng có thể gặp phải bao gồm nhóm chứng trước và sau thử nghiệm (thiết kế thử nghiệm ban đầu, được sử dụng rộng rãi nhất); chỉ sau thử nghiệm; nhóm nhân tố ngẫu nhiên (factorial, randomized block); và đo lường lặp lại (crossover/repeated measures) (Polit & Beck, 2008).

Một nghiên cứu thực nghiệm thực sự có ba tính năng đặc biệt: ngẫu nhiên, đối chứng và điều chỉnh. Sự ngẫu nhiên xảy ra khi nhà nghiên cứu chia các đối tượng vào nhóm đối chứng hoặc nhóm thử nghiệm trên cơ sở ngẫu nhiên, tương tự như việc tung xúc xắc. Điều này đảm bảo rằng mỗi đối tượng tiềm năng đáp ứng tiêu chuẩn chọn mẫu đều có cùng xác suất được lựa chọn cho thử nghiệm. Có nghĩa là, những người trong nhóm thử nghiệm và trong nhóm đối chứng nói chung sẽ giống hệt nhau, ngoại trừ việc đưa vào can thiệp hoặc điều trị thử nghiệm. Điều này rất quan trọng vì các đối tượng tham gia thử nghiệm đóng vai trò là đại diện cho dân số mà nhà nghiên cứu cảm thấy có thể có lợi trong tương lai từ việc can thiệp hoặc điều trị.

Điều chỉnh nghĩa là nhà nghiên cứu thực hiện thao tác nào đó với ít nhất một số đối tượng. Một can thiệp thử nghiệm được áp dụng cho một số đối tượng (nhóm thử nghiệm) và

không áp dụng cho những đối tượng khác (nhóm đối chứng) để ảnh hưởng đến một số khía cạnh về sức khỏe của họ. Khía cạnh mà nhà nghiên cứu đang cố gắng tác động là biến phụ thuộc (ví dụ: trải nghiệm đau thắt lưng).

Sự can thiệp thử nghiệm là biến số độc lập, hoặc hành động mà nhà nghiên cứu sẽ thực hiện (ví dụ: áp dụng nhiệt trị liệu mức độ thấp) để cố gắng thay đổi biến phụ thuộc.
Đối chứng thường đề cập đến việc giới thiệu một nhóm đối chứng hoặc nhóm so sánh, chẳng hạn như một nhóm đối tượng không được áp dụng can thiệp thử nghiệm. Mục đích là so sánh ảnh hưởng của việc không can thiệp lên biến phụ thuộc trong nhóm đối chứng với ảnh hưởng của can thiệp thực nghiệm đối với biến phụ thuộc trong nhóm thực nghiệm. Nên sử dụng giả dược bất cứ khi nào có thể vì một số đối tượng có thể phản ứng với chính giả dược; đây được gọi là hiệu ứng giả dược.

f. Nghiên cứu bán thực nghiệm

Thiết kế bán thực nghiệm tương tự như thiết kế thử nghiệm ở chỗ nó cố gắng chỉ ra rằng một can thiệp sẽ gây ra một kết quả cụ thể. Những thiết kế này được sử dụng khi việc chia nhóm thực nghiệm và nhóm chứng một cách ngẫu nhiên là không phù hợp với thực tế, đạo đức, hoặc không khả thi. Nghiên cứu này liên quan đến mức độ kiểm soát và điều chỉnh của điều tra viên đối với một biến độc lập. Tuy nhiên, chúng thiếu sự ngẫu nhiên, thành phần quan trọng của các nghiên cứu thực nghiệm. Vì không có ngẫu nhiên nên nhà nghiên cứu sẽ cố gắng bù đắp cho việc thiếu sự phân bố ngẫu nhiên, chẳng hạn như sử dụng nhiều nhóm hoặc nhiều lần đo lường (Trochim, 2006).

Ví dụ, điều tra viên có thể chia can thiệp ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm, ví dụ, hai cơ sở y tế, với một đơn vị can thiệp và một đơn vị là đối chứng. Điều tra viên không thể chia ngẫu nhiên những người tham gia vào các cơ sở, vì vậy đây không được xem là một thử nghiệm ngẫu nhiên. Điều chưa biết trong trường hợp này là cách người tham gia được đưa vào các cơ sở và nếu nó không thiên lệch và cơ hội là như nhau (Gliner, Morgan, & Leech, 2009).

Trong trường hợp một can thiệp cụ thể có hiệu quả, việc không áp dụng can thiệp sẽ là phi đạo đức. Tương tự như vậy, sẽ không thực tế nếu thực hiện một nghiên cứu đòi hỏi nhiều nhân lực, tài chính và vật lực hơn khả năng sẵn có. Đôi khi cả người bệnh và vị trí địa lý đều không thể ngẫu nhiên được.

Hãy xem xét điều tra viên muốn nghiên cứu ảnh hưởng của chuông báo rời giường đối với việc người bệnh té ngã. Sẽ không dễ dàng phân chia việc sử dụng chuông báo cho các phòng bệnh riêng lẻ hoặc cho từng người bệnh một cách ngẫu nhiên vì điều dưỡng có thể sẽ không đồng ý tắt chức năng báo động cho những người bệnh nguy cơ và đã được trang bị tính

năng an toàn này tại giường. Các thiết kế bán thực nghiệm mà nhóm EBP có thể phát hiện ra trong quá trình tìm kiếm bao gồm nhóm đối chứng không tương đương (so sánh) sau thử nghiệm và nhóm đối chứng không tương đương (so sánh) trước - sau thử nghiệm. Thuật ngữ không tương đương có nghĩa là không chỉ việc phân nhóm không ngẫu nhiên, mà nhà nghiên cứu không kiểm soát việc phân chia các nhóm. Do đó, các nhóm có thể khác nhau về các biến quan trọng như tình trạng sức khỏe hoặc nhân khẩu học, và sự khác biệt giữa các nhóm có thể ảnh hưởng đến kết quả. Các thiết kế bán thực nghiệm khác chỉ bao gồm một nhóm sau thử nghiệm, một nhóm trước thử nghiệm – sau thử nghiệm, có chuỗi thời gian, nhóm chứng đo lường lặp lại, can thiệp lặp lại trong đó các đối tượng đóng vai trò là đối chứng của riêng họ và thiết kế chéo (trong đó các đối tượng giống nhau tại các thời điểm khác nhau nhận được cả can thiệp thử nghiệm và đối chứng).

g. Các nghiên cứu phi thực nghiệm

Khi xem xét các bằng chứng liên quan đến các câu hỏi về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các câu hỏi liên quan đến điều dưỡng, các nhóm EBP sẽ nhận thấy rằng hầu hết các nghiên cứu đã được công bố đều phi thực nghiệm, hoặc là thiết kế quan sát. Nghiên cứu phi thực nghiệm gồm các nghiên cứu về hiện tượng xảy ra tự nhiên (nhóm, phương pháp điều trị và cá nhân). Những nghiên cứu này có thể đưa ra hoặc không đưa ra biện pháp can thiệp. Các đối tượng không được chia ngẫu nhiên vào các nhóm khác nhau, các biến số không bị điều chỉnh và điều tra viên không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát các khía cạnh của môi trường.

Các nghiên cứu định lượng phi thực nghiệm có thể được phân loại theo mục đích nghiên cứu và theo chiều thời gian (Belli, 2009). Ba nhóm phân loại theo mục đích hoặc ý định, là mô tả, dự đoán và giải thích. Nhóm phân loại theo thời gian là tiến cứu, theo chiều dọc và hồi cứu.

h. Thiết kế nghiên cứu mô tả

Mục đích của các thiết kế nghiên cứu mô tả thuần túy, như tên gọi của nó, là mô tả các đặc điểm của hiện tượng. Các câu hỏi cơ bản được hỏi trong nghiên cứu mô tả là, "Các giá trị có thể định lượng được của các biến số cụ thể đối với một nhóm đối tượng nhất định là gì? Một hiện tượng phổ biến như thế nào?" Các biến số không bị điều chỉnh và người ta không cố gắng xác định xem một can thiệp hoặc đặc tính cụ thể có gây ra một sự kiện cụ thể nào hay không. Các nhà điều tra cố gắng cung cấp tìm hiểu về ai, cái gì, ở đâu, khi nào và như thế nào về con người, địa điểm hoặc sự vật cụ thể. Người ta cố gắng mô tả câu trả lời cho những câu hỏi này bằng các thuật ngữ được đo lường chính xác. Phân tích thống kê thường được giới hạn ở tần số và giá trị trung bình. Các loại thiết kế mô tả phổ biến bao gồm mô tả đơn biến

(thường sử dụng phương pháp thăm dò hoặc khảo sát), nghiên cứu mô tả so sánh, mô tả tương quan và mô tả dịch tễ (tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mắc bệnh).

Với các thiết kế thăm dò, điều tra viên không biết đủ về một hiện tượng để xác định các biến quan tâm một cách hoàn toàn. Các biến được quan sát khi chúng xảy ra; không có nhà nghiên cứu nào kiểm soát được. Khi điều tra viên biết đủ về một hiện tượng cụ thể và có thể xác định các biến cụ thể, thiết kế khảo sát mô tả mô tả đầy đủ hơn hiện tượng. Bảng câu hỏi (khảo sát) hoặc kỹ thuật phỏng vấn để đánh giá các biến.

Các thiết kế mô tả so sánh xem xét và mô tả sự khác biệt về các biến giữa hai hoặc nhiều nhóm. Người ta không cố gắng xác định quan hệ nhân quả. Nói chung, thống kê mô tả, chẳng hạn như phân bố tần số và các số đo về độ tập trung (trung bình, trung vị và mode), được sử dụng để tóm tắt những khác biệt này. Các thiết kế tương quan mô tả tìm cách mô tả mối quan hệ giữa các biến. Một lần nữa, người ta không cố gắng để hiểu các mối quan hệ nhân quả. Người điều tra thu thập thông tin về ít nhất hai biến, tiến hành phân tích tương quan thống kê giữa hai biến để thu được hệ số tương quan - một số nằm trong khoảng từ –1 đến 1. Hệ số tương quan cho biết mối liên kết giữa hai biến. Nếu hệ số tương quan nằm trong khoảng từ 0 đến 1, thì mối tương quan là thuận, nghĩa là khi một biến tăng lên thì biến thứ hai cũng vậy. Tương quan nghịch được mô tả bằng hệ số tương quan giữa –1 và 0, có nghĩa là khi một biến tăng, biến kia giảm.

Hệ số tương quan cũng cho người đọc biết độ mạnh hoặc độ lớn của mối tương quan — nghĩa là, hệ số này càng gần 1 (nếu dương) hoặc –1 (nếu âm), thì mối liên hệ giữa hai biến càng mạnh.

Các nghiên cứu về tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mắc bệnh là các thiết kế mô tả được các nhà nghiên cứu dịch tễ học thường xuyên sử dụng (Polit & Beck, 2008). Mục đích của các nghiên cứu về tỷ lệ hiện mắc là xác định tỷ lệ dân số có bệnh cụ thể tại một thời điểm cụ thể (được gọi là tỷ lệ hiện mắc hoặc tỷ lệ hiện mắc tại một thời điểm). Điều này cung cấp cho các nhà nghiên cứu một số liệu hữu ích để hiểu rõ hơn gánh nặng của một căn bệnh cụ thể trong cộng đồng. Các nghiên cứu về tỷ lệ mắc bệnh tìm cách xác định tần suất những ca bệnh mới (hoặc tỷ lệ mới mắc) và rất hữu ích trong việc tìm hiểu nguy cơ phát triển bệnh.

i. Hướng dẫn lâm sàng

Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng (CPGs) là các tuyên bố và khuyến nghị được phát triển một cách có hệ thống nhằm mục đích tối ưu hóa việc chăm sóc và liên kết giữa nghiên cứu và thực hành bằng cách cung cấp hướng dẫn cho các nhà thực hành. “Các hướng dẫn thực hành lâm sàng được thông tin bởi các tổng quan hệ thống các bằng chứng và bao gồm các đánh giá về lợi ích và tác hại của các lựa chọn chăm sóc thay thế”. (IOM, 2011, trang 25–26). Hướng

dẫn thực hành lâm sàng đang được phát triển trên toàn cầu và được sử dụng để giảm bớt sự khác biệt về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cải thiện việc sử dụng nguồn lực và kết quả lâm sàng. Hướng dẫn thực hành lâm sàng được phát triển bởi các tổ chức như Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Mỹ (U.S. Preventive Services Taskforce - USPTF), các tổ chức chuyên khoa lâm sàng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc. Các hướng dẫn cũng được sửa dụng các nhà lâm sàng khi thực hành chăm sóc hoặc ở mức độ quản lý thực hiện phân tích chi phí/lợi ích để cải thiện kết quả lâm sàng, giảm chi phí chăm sóc và tạo sự hài lòng cho người bệnh và nhà cung cấp dịch vụ.

Phân tích chi phí/lợi ích sẽ là bước tiếp theo trong quá trình ra quyết định. Điều quan trọng là phải hiểu các vấn đề xung quanh sự xuất hiện của hướng dẫn thực hành lâm sàng và các yếu tố góp phần vào việc điều dưỡng, bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác sử dụng hoặc không sử dụng chúng. Sự phát triển nhanh chóng trong việc xây dựng hướng dẫn thực hành lâm sàng đã dẫn đến sự khác biệt lớn về mức độ nghiêm ngặt của nó và báo cáo về cách thức xây dựng hướng dẫn cũng như cách phân loại các khuyến nghị. Hãy nhớ rằng hướng dẫn lâm sàng có thể đạt mức độ rất nghiêm ngặt về mặt khoa học dựa trên bằng chứng – tức là mức độ I của bằng chứng phân tích gộp đến mức độ VII là từ ý kiến của các chuyên gia.

Về mặt áp dụng, hướng dẫn thực hành lâm sàng đôi khi được phát triển và viết ở các định dạng phức tạp gây khó khăn cho các nhà lâm sàng và tổ chức, hạn chế hiệu quả trong việc ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng và cải thiện kết quả của người bệnh. Do hướng dẫn thực hành lâm sàng có chất lượng khác nhau, nên điều cần thiết là các tổ chức và nhóm chăm sóc phải đánh giá chất lượng của chúng để xác định xem có nên thực hiện các hướng dẫn này trong thực hành chăm sóc ban đầu, cơ sở chăm sóc tại nhà hay cơ sở chăm sóc cấp tính hay không.

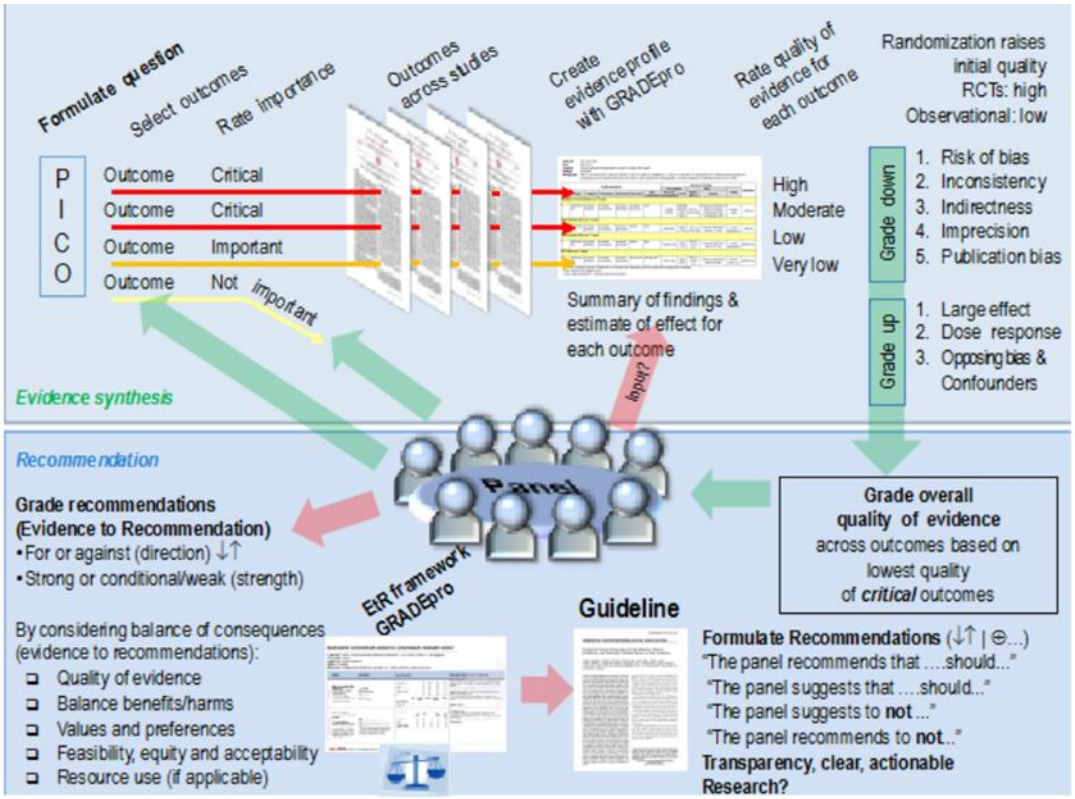
IOM (2011) đã xác định 8 tiêu chuẩn để phát triển các hướng dẫn thực hành lâm sàng đáng tin cậy:

1. Thiết lập sự minh bạch
2. Quản lý xung đột lợi ích
3. Thành phần nhóm phát triển hướng dẫn
4. Hướng dẫn thực hành lâm sàng (giao nhau giữa các tổng quan hệ thống)
5. Thiết lập cơ sở bằng chứng và đánh giá sức mạnh của các khuyến nghị
6. Phân tích các khuyến nghị
7. Đánh giá bên ngoài
8. Cập nhật

3. Đánh giá độ mạnh và chất lượng của bằng chứng nghiên cứu

Phương pháp GRADE là một hệ thống đánh giá chất lượng của bằng chứng trong các tổng quan hệ thống và tổng hợp bằng chứng khác, chẳng hạn như đánh giá công nghệ y tế, hướng dẫn và phân loại khuyến nghị trong chăm sóc sức khỏe. GRADE đưa ra một quy trình minh bạch và có cấu trúc để phát triển và trình bày tóm tắt bằng chứng và thực hiện các bước liên quan đến việc phát triển các khuyến nghị.

Nó có thể được sử dụng để phát triển các hướng dẫn thực hành lâm sàng (CPG) và các khuyến nghị chăm sóc sức khỏe khác (ví dụ như trong lĩnh vực y tế công cộng, chính sách và hệ thống y tế, các quyết định toàn diện).



Hình 2. Sơ đồ thể hiện cách tiếp cận GRADE trong đánh giá bằng chứng và các hướng dẫn thực hành lâm sàng

Nguồn: GRADE meeting, Edingburgh (2009)

GRADE (Phân loại các khuyến nghị, đánh giá, phát triển và lượng giá) là một sơ đồ rõ ràng để phát triển và trình bày tóm tắt bằng chứng và cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để đưa ra các khuyến nghị thực hành lâm sàng. Đây là công cụ được áp dụng rộng rãi nhất để đánh giá chất lượng của bằng chứng và để đưa ra các khuyến nghị với hơn 100 tổ chức trên toàn thế giới chính thức xác nhận GRADE.

GRADE có bốn mức độ bằng chứng - còn được gọi là độ chắc chắn về bằng chứng hoặc chất lượng của bằng chứng: rất thấp, thấp, trung bình và cao (Bảng 1). Bằng chứng từ các thử

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng bắt đầu ở chất lượng cao và do bị nhiễu, bằng chứng bao gồm dữ liệu quan sát bắt đầu ở chất lượng thấp. Độ chắc chắn của bằng chứng được tăng hoặc giảm vì một số lý do, được mô tả chi tiết hơn bên dưới.

Bảng 4.3. Xếp hạng mức độ bằng chứng theo GRADE

Mức độ chắc chắn	Mô tả
Rất thấp	Hiệu quả thực sự hầu như khác biệt so với hiệu quả ước tính
Thấp	Hiệu quả thực sự có thể có sự khác biệt rõ rệt so với hiệu quả ước tính
Trung bình	Tác giả tin rằng hiệu quả thực sự có thể gần với hiệu quả ước tính
Cao	Tác giả tự tin rằng hiệu quả thực sự tương đồng với hiệu quả ước tính

Hồ sơ bằng chứng GRADE chứa thông tin chi tiết về chất lượng của việc đánh giá bằng chứng và bản tóm tắt các kết quả. Nó dành cho các tác giả đánh giá, những người chuẩn bị các bảng SoF và bất kỳ ai đặt câu hỏi về đánh giá chất lượng. Nó giúp những người chuẩn bị các bảng SoF đảm bảo rằng các phán đoán mà họ đưa ra là có hệ thống và minh bạch và nó cho phép những người khác kiểm tra các phán đoán đó. Ban hướng dẫn nên sử dụng hồ sơ bằng chứng để đảm bảo rằng họ đồng ý về các phán quyết làm cơ sở cho các đánh giá chất lượng.

Một hồ sơ bằng chứng GRADE cho phép trình bày thông tin chính về tất cả các kết quả có liên quan cho một câu hỏi về chăm sóc sức khỏe. Nó trình bày thông tin về cơ sở của bằng chứng (ví dụ: số lượng nghiên cứu), các đánh giá về chất lượng cơ bản của bằng chứng, các kết quả thống kê chính và chất lượng đánh giá bằng chứng cho mỗi kết quả.

- Danh sách các kết quả
- Nguy cơ giả định; thước đo gánh nặng điển hình của các kết quả, tức là nguy cơ minh họa hoặc còn được gọi là nguy cơ cơ bản, điểm nền hoặc nguy cơ nhóm chứng
- Nguy cơ tương ứng; thang đo gánh nặng của các kết quả sau khi áp dụng can thiệp, tức là nguy cơ về kết quả ở những người được điều trị/tiếp xúc dựa trên mức độ tương đối của một tác động và nguy cơ giả định (nguy cơ cơ bản)
- Ảnh hưởng tương đối; đối với các kết quả phân đôi, bảng thường sẽ cung cấp tỷ số nguy cơ, tỷ số chênh hoặc tỷ lệ rủi ro
- Số lượng người tham gia và số lượng nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu
- Đánh giá chất lượng tổng thể của bằng chứng cho từng kết quả (có thể khác nhau tùy theo kết quả)
- Chú thích hoặc giải thích, nếu cần, để cung cấp giải thích về thông tin trong bảng
- Nhận xét (nếu cần).

*** Giảm xếp hạng GRADE**

a. Nguy cơ sai lệch

Sự sai lệch xảy ra khi kết quả của một nghiên cứu không đại diện cho sự thật vì những hạn chế cố hữu trong thiết kế hoặc tiến hành một nghiên cứu. Trong thực tế, rất khó để biết mức độ ảnh hưởng của sự sai lệch tiềm tàng đến kết quả và do đó độ chắc chắn sẽ thấp hơn đối với ảnh hưởng ước tính nếu các nghiên cứu thông báo về ảnh hưởng ước tính có thể bị sai lệch.

Có một số công cụ để đánh giá nguy cơ sai lệch trong các thử nghiệm ngẫu nhiên riêng lẻ và các nghiên cứu quan sát.

GRADE được sử dụng để đánh giá bằng chứng ở cấp độ kết quả hơn là cấp độ nghiên cứu. Do đó, các tác giả phải đưa ra đánh giá về việc liệu nguy cơ sai lệch trong các nghiên cứu riêng lẻ có đủ lớn để khiến họ tin rằng hiệu quả điều trị ước tính thấp hơn hay không.

b. Tính không chính xác

Phương pháp GRADE để xếp hạng không chính xác tập trung vào 95% khoảng tin cậy xung quanh ước tính tốt nhất về hiệu quả tuyệt đối. Độ chắc chắn sẽ thấp hơn nếu quyết định lâm sàng có khả năng khác nếu hiệu quả thực sự ở đầu trên so với đầu dưới của khoảng tin cậy. Các tác giả cũng có thể chọn giảm tỷ lệ không chính xác nếu ước tính hiệu quả chỉ đến từ một hoặc hai nghiên cứu nhỏ hoặc nếu có ít sự kiện.

c. Tính không nhất quán

Độ chắc chắn trong một bằng chứng là cao nhất khi có một số nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng nhất quán. Khi xem xét liệu độ chắc chắn có nên bị giảm hạng do tính không nhất quán hay không, các tác giả nên kiểm tra sự giống nhau của các ước lượng điểm và sự trùng lặp giữa các khoảng tin cậy, cũng như các tiêu chí thống kê về tính không đồng nhất (ví dụ: kiểm định I2 và kiểm định chi bình phương).

d. Tính gián tiếp

Bằng chứng là chắc chắn nhất khi các nghiên cứu so sánh trực tiếp các biện pháp can thiệp ở đối tượng và báo cáo (các) kết quả quan trọng cho việc ra quyết định. Độ chắc chắn có thể được đánh giá thấp nếu những người bệnh được nghiên cứu khác với những người bệnh mà khuyến nghị áp dụng. Tính gián tiếp cũng có thể xảy ra khi các biện pháp can thiệp được nghiên cứu khác với kết quả thực tế (ví dụ, một nghiên cứu về một phương pháp phẫu thuật mới ở một trung tâm chuyên môn cao chỉ áp dụng gián tiếp cho những trung tâm có ít kinh nghiệm hơn). Tính gián tiếp cũng xảy ra khi kết quả nghiên cứu là đại diện cho một kết quả khác - thường là kết quả quan trọng hơn đối với người bệnh. Bàn luận đầy đủ về tính gián tiếp có trong loạt bài hướng dẫn số 8: đánh giá chất lượng của bằng chứng - tính gián tiếp.

e. Sai lệch trong công bố

Sai lệch trong công bố có lẽ là điều gây khó chịu nhất trong các lĩnh vực GRADE, bởi vì nó đòi hỏi phải đưa ra những suy luận về các bằng chứng còn thiếu. Một số phương pháp thống kê và trực quan rất hữu ích trong việc phát hiện sai lệch công bố, mặc dù có những hạn chế nghiêm trọng. Sự sai lệch về công bố phổ biến hơn với dữ liệu quan sát và khi hầu hết các nghiên cứu được công bố được tài trợ bởi ngành công nghiệp.

**** Mẹo để đọc nghiên cứu***

- Tiêu đề: Khi tìm kiếm bằng chứng nghiên cứu bằng văn bản, nhóm EBP bắt gặp danh sách các tiêu đề có liên quan. Tiêu đề trình bày điểm khởi đầu trong việc xác định xem liệu bài báo có được đưa vào đánh giá EBP hay không. Tốt nhất, tiêu đề nên mang tính thông tin và giúp người đọc hiểu loại nghiên cứu nào đang được báo cáo.

- Phần tóm tắt: Phần tóm tắt thường nằm sau phần tiêu đề và tác giả và được phân biệt bằng hình ảnh bằng cách sử dụng khung, in đậm hoặc in nghiêng. Một bản tóm tắt tốt chứa thông tin về mục đích, phương pháp, kết quả, kết luận và mức độ phù hợp lâm sàng của một nghiên cứu.

- Phần mở đầu: Nếu phần tóm tắt có vẻ có liên quan, nhóm nên chuyển sang phần kiểm tra phần giới thiệu sau đó. Phần giới thiệu bao gồm thông tin cơ bản cũng như nêu vấn đề cho biết lý do tại sao các nhà điều tra đã chọn thực hiện một nghiên cứu cụ thể. Thông tin cơ bản tốt nhất nên được trình bày trong bối cảnh của một tổng quan tài liệu hiện tại, và tác giả nên xác định khoảng cách kiến thức giữa những gì đã biết và những gì nghiên cứu muốn tìm ra (hoặc câu trả lời). Cần có một tuyên bố rõ ràng, trực tiếp về mục đích cũng như tuyên bố về các kết quả hoặc giả thuyết dự kiến. Tuyên bố về mục đích thường, mặc dù không phải luôn luôn, nằm ngay trước tiêu đề chính đầu tiên của bài viết.

- Kết luận: Phần kết luận nên trình bày lại ngắn gọn các kết quả và hàm ý của nghiên cứu (Lunsford & Lunsford, 1996). Nếu kết luận không được đưa ra bằng một tiêu đề riêng, nó thường nằm ở cuối phần bàn luận.

- Phương pháp: Phần này mô tả cách một nghiên cứu được tiến hành (các quy trình nghiên cứu) một cách đầy đủ chi tiết để người đọc có thể lặp lại nghiên cứu, nếu muốn. Ví dụ, nếu can thiệp là sử dụng giả dược, thì bản chất của giả dược phải được nêu rõ. Điều tra viên nên xác định quần thể nghiên cứu dự kiến và cung cấp mô tả về các tiêu chuẩn chọn mẫu và tiêu chuẩn loại trừ. Đối tượng được tuyển chọn như thế nào và đặc điểm nhân khẩu học của những người thực sự tham gia nghiên cứu nên được đưa vào. Ngoài ra, nếu sử dụng thiết bị đo, phần phương pháp phải trình bày bằng chứng về chất lượng của thiết bị, ngay cả khi sử dụng các

công cụ phổ biến, đã được công bố. Cuối cùng, báo cáo phải có mô tả về cách dữ liệu được thu thập và phân tích.

- Kết quả: Kết quả nghiên cứu liệt kê các kết quả phân tích dữ liệu và không được chứa bình luận. Đặc biệt chú ý đến các số liệu và bảng biểu, vốn là trọng tâm của hầu hết các bài báo. Quan sát xem liệu kết quả có báo cáo ý nghĩa thống kê so với ý nghĩa lâm sàng hay không và tra cứu thuật ngữ, ký hiệu hoặc logic không quen thuộc.

- Bàn luận: Kết quả nên gắn liền với tài liệu trong phần mở đầu. Các kết quả nghiên cứu nên được bàn luận và đưa ra ý nghĩa cho các kết quả. Các điểm yếu hoặc hạn chế chính của nghiên cứu cần được xác định bằng các hành động được thực hiện để giảm thiểu chúng, và ý nghĩa rộng rãi của các kết quả cần được nêu rõ.

Người đánh giá cần được cảnh báo rằng người viết có thể sử dụng ngôn ngữ để làm người đọc bị lung lay. Trong cuộc bàn luận kinh điển về đọc nghiên cứu, Graham (1957) lưu ý rằng các nhà nghiên cứu có thể phóng đại kết quả của họ hoặc sử dụng một câu khẳng định theo cách làm cho tuyên bố về kết quả của họ giống như một sự thật đã được chứng minh rõ ràng. (Xem xét một cách nghiêm túc các cách diễn đạt mơ hồ kiểu như “Người ta thường tin rằng….”).

CHƯƠNG V.
TẠO MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ CHO THỰC HÀNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

Tại sao phải quan tâm đến việc tạo ra một môi trường hỗ trợ cho hoạt động thực hành dựa trên bằng chứng (EBP)? Câu trả lời rõ ràng nhất là bằng chứng mới liên tục xuất hiện trong môi trường thực hành điều dưỡng và y học. Các nhà thực hành phải kết hợp sự gia tăng đáng kể của việc tạo ra kiến thức mới vào thói quen hàng ngày để việc thực hành của họ dựa trên bằng chứng, tuy nhiên vẫn có sự chậm trễ trong việc triển khai kiến thức mới vào môi trường thực hành. Balas & Boren (2000) đã trích dẫn 17 năm là thời gian trung bình từ khi tạo ra bằng chứng mới cho đến khi triển khai bằng chứng đó vào thực tế.

Ngoài ra, để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cập nhật các tạp chí phù hợp với thực tế, mỗi người hành nghề cần đọc 17 bài báo mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm (Balas & Boren, 2000). Môi trường chăm sóc sức khỏe năng động và cạnh tranh đòi hỏi những người hành nghề chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả. Môi trường này cũng yêu cầu cải tiến liên tục các quy trình và kết quả chăm sóc. Chăm sóc sức khỏe, được cung cấp trong cơ cấu của một hệ thống hoặc tổ chức, có thể tạo điều kiện hoặc ngăn cản việc thu nhận bằng chứng. EBP yêu cầu tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học tập suốt đời để tăng cường sử dụng bằng chứng trong thực tế.

1. Chọn mô hình thực hành dựa trên bằng chứng

Cần có một khuôn mẫu tiêu chuẩn cho việc yêu cầu áp dụng thực hành dựa trên bằng chứng trong tổ chức để thực hiện các phương pháp thực hành tốt nhất cả về mặt lâm sàng và quản lý, để xác định và cải thiện các thành phần chi phí chăm sóc, thúc đẩy cải thiện kết quả và đảm bảo thành công của sáng kiến thực hành dựa trên bằng chứng.

Cần xem xét đánh giá kỹ lưỡng bất kỳ mô hình hoặc khuôn mẫu EBP nào đang được xem xét để áp dụng thông qua các tiêu chí gợi ý như sau:

■ Sự phù hợp và khả thi của mô hình với tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý và các giá trị của tổ chức và đơn vị chăm sóc.

■ Nền tảng giáo dục, khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm và nhu cầu thực hành của điều dưỡng.

■ Sự hiện diện của bất kỳ quan hệ đối tác nào cho sáng kiến EBP, chẳng hạn như trường điều dưỡng hoặc hợp tác với các ngành nghề khác, chẳng hạn như y học, dược, dinh dưỡng.

■ Văn hóa và môi trường của tổ chức.

■ Sự sẵn có và khả năng tiếp cận các nguồn bằng chứng nội bộ hoặc bên ngoài tổ chức

2. Tạo và xây dựng điều kiện môi trường thuận lợi hỗ trợ thực hành dựa trên bằng chứng

Để thúc đẩy sáng kiến thực hành dựa trên bằng chứng, ban lãnh đạo của tổ chức phải đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng thích hợp luôn sẵn có và được hỗ trợ. Cơ sở hạ tầng tổ chức bao gồm nguồn nhân lực và vật lực và văn hóa tiếp thu. Các giả định chính liên quan đến thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng bao gồm:

■ Điều dưỡng vừa là một ngành khoa học vừa là một nghề ứng dụng.

■ Kiến thức quan trọng đối với thực hành nghề nghiệp, và phải xác định những giới hạn về kiến thức.

■ Không phải tất cả các bằng chứng được tạo ra đều như nhau, và cần phải sử dụng bằng chứng tốt nhất hiện có.

■ Thực hành dựa trên bằng chứng góp phần cải thiện kết quả. (Newhouse, 2007).

Việc truyền tải thành công thực hành dựa trên bằng chứng trong toàn bộ tổ chức phải tập trung vào ba chiến lược chính: thiết lập văn hóa, xây dựng năng lực và đảm bảo tính bền vững.

3. Thiết lập văn hóa tổ chức

Thiết lập văn hóa thực hành dựa trên bằng chứng là một sự thay đổi do lãnh đạo điều hành, về cơ bản là những thách thức chung về niềm tin trong thực hành điều dưỡng. Sự thay đổi mang tính biến đổi này trong văn hóa thường xảy ra trong khoảng thời gian 3-5 năm. Trong thời gian này, thực hành dựa trên bằng chứng được lồng ghép với các giá trị, chuẩn mực và cấu trúc của đơn vị điều dưỡng thông qua cách tiếp cận có kế hoạch và có hệ thống.

Schein (2004) định nghĩa văn hóa tổ chức là "các khuôn mẫu của các giả định cơ bản được chia sẻ mà một nhóm đã học được khi giải quyết các vấn đề về khả năng thích ứng bên ngoài và hội nhập nội bộ, đã hoạt động tốt… được dạy cho các thành viên mới như một cách nhận thức, suy nghĩ, cảm nhận đúng trong mối quan hệ với những vấn đề này" (tr. 17). Do đó, văn hóa là nguồn lực mạnh hoạt động ngầm, hướng dẫn, hạn chế và/hoặc ổn định hành vi của các thành viên trong nhóm thông qua các chuẩn mực chung của nhóm (Schein, 2004).

Mặc dù các tổ chức phát triển các nền văn hóa riêng biệt, các nền văn hóa phụ cũng hoạt động ở cấp độ đơn vị hoặc đội ngũ và tạo ra một bối cảnh để thực hành. Việc xây dựng một nền văn hóa dựa trên thực hành đòi hỏi các nhà lãnh đạo điều dưỡng ở tất cả các cấp phải thách thức truyền thống, đặt ra các kỳ vọng và vai trò kiểu mẫu trong việc sử dụng bằng chứng làm cơ sở cho các quyết định và yêu cầu tất cả các cấp nhân viên phải chịu trách nhiệm về những hoạt động này.

Công việc hữu hình và hiển nhiên là thiết lập một nền văn hóa ủng hộ thực hành dựa trên bằng chứng đòi hỏi phải xem xét lại triết lý điều dưỡng, phát triển một kế hoạch chiến lược, đảm bảo các nhà lãnh đạo cam kết, xác định và khai thác việc sử dụng các cố vấn và các nhà lãnh đạo không chính thức, đồng thời vượt qua các rào cản.

4. Xem lại Triết lý Điều dưỡng

Một cách hữu hình để báo hiệu sự thay đổi đối với văn hóa thực hành dựa trên bằng chứng và đặt nền tảng cho sự cam kết của các nhà lãnh đạo là xem xét và thay đổi triết lý cho đơn vị điều dưỡng. Tuyên bố này nên bao gồm một số điểm chính như sau:

Đầu tiên, triết lý phải nói lên tinh thần tìm hiểu và học tập suốt đời cần thiết cho việc thực hành dựa trên bằng chứng.

Thứ hai, nó phải đưa ra một môi trường làm việc đòi hỏi và hỗ trợ trách nhiệm giải trình của điều dưỡng đối với việc thực hành và ra quyết định.

Cuối cùng, triết lý cần bao gồm mục tiêu cải thiện kết quả chăm sóc người bệnh thông qua việc ra quyết định hành chính và lâm sàng dựa trên bằng chứng.

5. Xây dựng kế hoạch chiến lược

Lãnh đạo cấp điều hành phải hỗ trợ và cam kết, bao gồm cả giám đốc điều hành điều dưỡng (CNE), phải tham gia vào việc tạo ra và phát triển môi trường thực hành dựa trên bằng chứng. Để vận hành tuyên bố triết lý và xây dựng năng lực thực hiện EBP, các nhà lãnh đạo của tổ chức phải phát triển một kế hoạch chiến lược để xác định các mục tiêu, khung thời gian, trách nhiệm và quá trình đánh giá. Kế hoạch cũng yêu cầu cam kết phân bổ nguồn lực đầy đủ cho sáng kiến EBP, bao gồm con người, thời gian, tiền bạc, giáo dục và cố vấn chuyên môn.

Là một mục tiêu chiến lược, thực hành dựa trên bằng chứng cần được thực hiện ở tất cả các cấp của tổ chức. Khi sáng kiến được đưa ra, các nhà lãnh đạo cần kiểm tra nhịp độ của tổ chức và chuẩn bị để sửa đổi chiến lược khi cần thiết. Để hỗ trợ quá trình này, họ nên xác định các rào cản tiềm ẩn đối với việc thực hiện, có kế hoạch giảm hoặc loại bỏ chúng, đồng thời hỗ trợ các giám đốc dự án và thay đổi chiến lược theo mọi cách có thể.

6. Đảm bảo lãnh đạo tổ chức cam kết thực hiện

Khi các nhà lãnh đạo tích cực tham gia và thường xuyên được tham vấn, thì khả năng thành công của việc thực hiện, tính bền vững và cơ sở hạ tầng ổn định sẽ cao hơn. Khi các nhà lãnh đạo không tham gia, quá trình thay đổi và chuyển đổi sẽ mang tính phản ứng hơn là chủ động, và cơ sở hạ tầng và tính bền vững theo thời gian kém chắc chắn hơn.

7. Xác định và Phát triển các cố vấn và lãnh đạo không chính thức

Các cố vấn và những người tiên phong có vai trò quan trọng trong việc đồng hóa thực hành dựa trên bằng chứng vào văn hóa tổ chức. Họ cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trợ để nhân viên thoát ra khỏi vùng an toàn của họ khi họ học các kỹ năng và năng lực mới.

Các nhà lãnh đạo không chính thức có ảnh hưởng đến nhân viên ở cấp đơn vị hoặc cấp phòng ban. Sự hiện diện và ảnh hưởng của cả hai vai trò là thuộc tính then chốt cho sự bền vững và xây dựng năng lực trong đội ngũ nhân viên. Bởi vì thực hành dựa trên bằng chứng là một thay đổi do lãnh đạo định hướng, nên xác định và thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính thức và không chính thức sớm và thường xuyên trong việc tạo ra các chiến lược thay đổi và chuyển đổi để họ có thể đóng vai trò là người ủng hộ chứ không phải là đối thủ cho sự thay đổi và vai trò khuôn mẫu được áp dụng trong thực tế.

Ban lãnh đạo phải xác định và lựa chọn những người cố vấn một cách cẩn thận, chọn họ từ khắp tổ chức — các ngành nghề, cấp độ và chuyên môn khác nhau. Xem xét xem ai trong tổ chức có kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy một sáng kiến thực hành dựa trên bằng chứng, có thể cung cấp hỗ trợ tốt nhất và có nhiều lợi ích nhất để thấy rằng thực hành dựa trên bằng chứng thành công. Việc xây dựng các kỹ năng và kiến thức của người cố vấn nên tính đến những câu hỏi như, “Người cố vấn sẽ được đào tạo như thế nào? Ai sẽ cung cấp khóa đào tạo ban đầu? Họ sẽ được hỗ trợ như thế nào và bởi ai sau khi khóa đào tạo của họ hoàn thành? ” Khi các hoạt động xây dựng môi trường thực hành dựa trên bằng chứng gia tăng, ban lãnh đạo cần phổ biến các hoạt động giáo dục và cố vấn trong toàn bộ nhân viên điều dưỡng.

Chìa khóa thành công là tăng sự tham gia bằng cách thu hút càng nhiều nhân viên càng tốt để hỗ trợ quá trình thực hành dựa trên bằng chứng bằng cách tập trung vào một vấn đề quan trọng đối với họ. Có thể phát triển người cố vấn theo nhiều cách. Ban đầu, nếu tổ chức chưa phát triển được các chuyên gia trong đội ngũ nhân viên của mình, tổ chức có thể tìm người cố vấn thông qua các cơ hội hợp tác bên ngoài tổ chức, chẳng hạn như quan hệ đối tác với các trường điều dưỡng hoặc tham vấn với các tổ chức và chuyên gia đã phát triển mô hình. Sau khi chuyên môn nội bộ được thiết lập, việc triển khai thực hành dựa trên bằng chứng trong toàn bộ tổ chức dẫn đến một cơ chế tự tạo để phát triển các cố vấn. Ví dụ: thành viên của các ủy ban tham gia vào các dự án thực hành dựa trên bằng chứng do một người cố vấn hướng dẫn sẽ nhanh chóng trở thành người cố vấn cho các nhân viên, ủy ban hoặc nhóm khác đang

tham gia vào công việc thực hành dựa trên bằng chứng. Hợp tác thực hành dựa trên bằng chứng là một cách khác để phát triển người cố vấn trong đó đồng nghiệp có được kỹ năng lãnh đạo và tham khảo ý kiến của các nhóm nhân viên trong bộ nội bộ đơn vị của họ hoặc trong toàn bộ tổ chức.

Bằng chứng chỉ ra rằng các điều dưỡng, khi đối mặt với một mối quan tâm lâm sàng, thích hỏi đồng nghiệp hơn là tìm kiếm trên tạp chí, sách hoặc internet để tìm câu trả lời. Các đồng nghiệp được tìm đến thường là những nhà lãnh đạo không chính thức và bằng chứng chỉ ra rằng những nhà lãnh đạo không chính thức này — những nhà lãnh đạo có quan điểm và thay đổi thành công — có hiệu quả trong việc thay đổi hành vi của các nhóm nếu được sử dụng kết hợp với phản hồi về giáo dục và hiệu suất (Titler, 2008). Các nhà lãnh đạo chính thức khác với các nhà lãnh đạo không chính thức ở chỗ các nhà lãnh đạo chính thức có vị trí quyền lực; trong khi quyền lực của các nhà lãnh đạo không chính thức bắt nguồn từ địa vị, chuyên môn và ý kiến của họ trong một nhóm.

8. Phát triển kỹ năng và kiến thức thực hành dựa trên bằng chứng

Năng lực xây dựng hướng đến đội ngũ nhân viên với kiến thức, kỹ năng và nguồn lực để thu thập và đánh giá giá trị của bằng chứng và chuyển nó vào thực tế. Việc phát triển năng lực sử dụng và áp dụng thực hành dựa trên bằng chứng được thực hiện tốt nhất thông qua giáo dục và thực hành trực tiếp qua công trình của các nhóm liên ngành.

***TÓM LẠI**

Sự cần thiết phải tạo ra một môi trường hỗ trợ thực hành dựa trên bằng chứng là một trong những bài học quan trọng nhất. Cơ bản của nỗ lực đó là sự công nhận tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực cho thực hành dựa trên bằng chứng. Lãnh đạo ủng hộ là điều cần thiết để thiết lập văn hóa thực hành dựa trên bằng chứng, bao gồm việc mở rộng cơ sở hạ tầng và phân bổ các nguồn lực như thời gian, tiền bạc và con người để duy trì sự thay đổi. Các nhà lãnh đạo đặt ra các ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình và đặt ra các kỳ vọng. Sự phát triển của các cố vấn và các nhà tiên phong tại chỗ góp phần vào việc thực hiện thành công thực hành dựa trên bằng chứng và giúp vượt qua các rào cản và sự kháng cự đối với thực hành dựa trên bằng chứng.

Văn hóa tư duy phản biện và học tập liên tục tạo ra một môi trường nơi bằng chứng hỗ trợ các quyết định hành chính và lâm sàng, đảm bảo chất lượng chăm sóc cao nhất bằng cách sử dụng bằng chứng để thúc đẩy kết quả tối ưu, giảm sự khác biệt không phù hợp trong chăm sóc và thúc đẩy sự hài lòng của người bệnh và nhân viên. Làm việc trong môi trường thực hành dựa trên bằng chứng thay đổi cách các điều dưỡng nghĩ về và tiếp cận công việc đó. Khi điều dưỡng phát triển chuyên môn trong quá trình thực hành dựa trên bằng chứng, sự phát

triển chuyên môn và sự tham gia của họ bắt đầu theo quỹ đạo cá nhân và tổ chức dẫn đến các quyết định dựa trên bằng chứng, mức độ đánh giá nghiêm túc bằng chứng cao hơn và tham gia vào nhóm liên ngành với tư cách là những người đóng góp có giá trị.

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU XÂY DỰNG CÂU HỎI LÂM SÀNG DẠNG PICOT

1. Dạng câu hỏi can thiệp

Trong _____ (P), _____ (I) so với _____ (C) ảnh hưởng như thế nào_____ (o) trong vòng _____ (T)?

2. Dạng câu hỏi căn nguyên

_____ (P) có _____ (I) được so sánh với những người không có_____ (C) có nguy cơ _____ đối với / trong số _____ (C) trên_____ (T)?

3. Dạng câu hỏi chẩn đoán hoặc xét nghiệm chẩn đoán

Ở _____ (P), là / là _____ (I) so với _____ (C) chính xác hơn trong chẩn đoán _____ (O)?

4. Dạng câu hỏi đề xuất / dự kiến

Trong _____ (P), _____ (I) như thế nào so với _____ (C) ảnh hưởng _____ (O) trong / hơn _____ (T)?

5. Dạng câu hỏi diễn giải ý nghĩa

Làm thế nào để _____ (P) với _____ (I) cảm nhận _____ (O) trong khi_____ (tT?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bernadette Mazurek Melnyk, Ellen Fineout – Overholt (2019), *Evidence – based practice in Nursing and Healthcare – A guide to best practice*, Wolters Kluwer.

2. Butler, M. (2017), Making HIPAA work for consumers, *Journal of American Health Information Management Association*, 88(3), 14–17.

3. Jones and Barlett (2017), *Introduction to Evidence – Based Practice*, LLC Company.

4. Melnyk, B. and Fineout-Overholt, E. (2010), Evidence-Based Practice: Step by Step. The Seven Steps of Evidence-Based Practice: Following This Progressive, Sequential Approach Will Lead to Improved Healthcare and Patient Outcomes, *American Journal of Nursing*, 110, pp.51-53.

5. Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2015), *Making the case for evidence-based practice and cultivating a spirit of inquiry. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice*, 3th edition, Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.

6. Sandra L.Dearholt & Deborah Dang (2012), *Johns Hopkins Nursing - Evidence-Based Practice: Model and Guidelines*, 2th edition, Sigma Theta Tau International.

7. WHO (2017), *Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region*, WHO Regional Office for Europe, pp. 8-11.